Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(ГБУЗ МО «МОКПТД»)

ПРИКАЗ

«21» мая 2024 № 116/24

Об обращении лекарственных средств
и медицинских изделий в ГБУЗ МО «МОКПТД»

На основании Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказа Минздравсоцразвития от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», приказов Минздрава России от 22.04.2014 №183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», от 17.06.2013 №378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Инструкцию о порядке получения, учета, выдачи и списания лекарственных средств и медицинских изделий из аптеки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее по тексту - ГБУЗ МО «МОКПТД») (Приложение 1);

1.2. Инструкцию по маркировке упаковок лекарственных средств (Приложение 2);

1.3. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в аптеке ГБУЗ МО «МОКПТД» (Приложение 3);

1.4. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий на постах медицинских сестер стационарных отделений» (Приложение 4);

1.5. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в процедурных, перевязочных

кабинетах, кабинетах врачей-специалистов и реанимационных залах стационарных отделений» (Приложение 5);

1.6. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий у старших медицинских сестер стационарных отделений» (Приложение 6);

1.7. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в кабинетах выдачи пациентам лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения» (Приложение 7);

1.8. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в процедурных кабинетах филиалов и их структурных подразделений, осуществляющий амбулаторный этап лечения пациентов и в приемных отделениях стационаров» (Приложение 8);

1.9. Стандартную операционную процедуру «О хранении лекарственных средств и медицинских изделий у старших медицинских сестер филиалов и их структурных отделений, осуществляющих амбулаторный этап лечения пациентов» (Приложение 9);

1.10. Стандартную операционную процедуру «Порядок хранения термолабильных лекарственных средств и иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) в аптеке и структурных подразделениях ГБУЗ МО «МОКПТД» (Приложение 10);

1.11. Стандартную операционную процедуру «Правила использования хладоэлементов и их хранения» (Приложение 11);

1.12. Алгоритм закладки термоконтейнера BlueLin Bag 30L (для ИЛП, термолабильных препаратов, крови и ее компонентов) (Приложение 12);

1.13. Алгоритм закладки термоконтейнера TransPorter BlueLin Bag 30L (для плазмы) (Приложение 13);

1.14. Алгоритм действий персонала в случае отключения электроэнергии (Приложение 14);

1.15. Стандартную операционную процедуру «Порядок хранения дезинфицирующих препаратов» (Приложение 15);

1.16. Стандартную операционную процедуру «Выдача лекарственных средств пациентам в стационарных отделениях» (Приложение 16);

1.17. Стандартную операционную процедуру «Правила обращения с личными лекарственными средствами пациентов в стационарных отделениях» (Приложение 17);

1.18. Стандартную операционную процедуру «Использование гигрометра психрометрического ВИТ-1, ВИТ-2» (Приложение 18);

1.19. Алгоритм выдачи лекарственных средств по видеоконтролируемому лечению с использованием видеофайла (Приложение 19);

1.20. Алгоритм выдачи лекарственных средств пациенту на амбулаторном этапе лечения (Приложение 20);

1.21. Памятку для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (Приложение 21);

1.22. Памятку для медицинских сестер при рассыпании или проливании лекарственных средств (Приложение 22);

1.23. Форму журнала учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения (для аптеки) (Приложение 23);

1.24. Форму журнала учета движения ИЛП (для Диаскин-теста, туберкулина) (Приложение 24);

1.25. Форму журнала учета транспортировки донорской крови и ее компонентов (Приложение 25);

1.26. Форму журнала учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения (для старших медицинских сестер отделений, постов медицинских сестер, процедурных и функциональных кабинетов) (Приложение 26);

1.27. Форму журнала регистрации температуры в холодильном оборудовании (Приложение 27);

1.28. Форму журнала учета параметров микроклимата (Приложение 28);

1.29. Форму отчета о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (Приложение 29);

1.30. Форму журнала учета транспортировки иммунобиологических лекарственных препаратов, термолабильных лекарственных средств (Приложение 30).

2. Старшим медицинским сестрам филиалов и их структурных подразделений:

2.1. получать лекарственные средства и медицинские изделия в аптеке ГБУЗ МО «МОКПТД» с запасом, не превышающем один месяц, а дезинфицирующие средства по разнарядке главной медицинской сестры в соответствии с Приложением 1.

2.2. выдавать:

лекарственные средства, медицинские изделия на посты медицинских сестер, в кабинеты выдачи пациентам лекарственных средств на амбулаторном этапе лечения, процедурные и перевязочные кабинеты с запасом, не превышающем трех дней;

дезинфицирующие средства лицам, осуществляющим дезинфекционные работы по мере расходования, не допуская хранения запаса в санитарных комнатах и процедурных кабинетах.

3. Старшим медицинским сестрам структурных подразделений Клиники № 1, Клиники №2, стационара «Сукманиха» и медицинским сестрам, ответственным за получение лекарственных средств, медицинских изделий:

3.1. получать лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету в аптеке ГБУЗ МО «МОКПТД» в соответствии с Приложением 1, с запасом на одну неделю;

прочие лекарственные средства и медицинские изделия на 14 дней;

дезинфицирующие средства на один месяц.

3.2. выдавать лекарственные средства и медицинские изделия на посты медицинских сестер, в процедурные и перевязочные кабинеты не более, чем на три дня. Дезинфицирующие средства выдавать лицам, осуществляющим дезинфекционные работы по мере расходования, не допуская хранения запаса в санитарных комнатах и процедурных кабинетах.

4. Заведующему аптекой ГБУЗ МО «МОКПТД» и старшим медицинским сестрам филиалов, структурных подразделений Клиники № 1, Клиники №2, стационара «Сукманиха» и медицинским сестрам, ответственным за получение лекарственных препаратов и расходных медицинских изделий, обеспечить:

- учет лекарственных средств в соответствии с Приложением 1;
- маркировку упаковок лекарственных средств в соответствии с Приложением 2.

5. Назначить ответственными за исполнение требований настоящего приказа в структурных подразделениях ГБУЗ МО «МОКПТД» старших медицинских сестер филиалов и клиник и старших медицинских сестер структурных подразделений клиник и филиалов.

6. Заведующему аптекой и главной медицинской сестре осуществлять контроль за соблюдением требований, предусмотренных приказом в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части Лапыреву И.А.

8. Приказ ГБУЗ МО «МОКПТД» от 27.03.2023 №110/23 «Об утверждении порядка получения, хранения и учета лекарственных средств, расходных медицинских изделий и дезинфицирующих средств», приложение 5 приказа ГБУЗ МО МОКПТД от 18.04.2024 № 94/24 «Об утверждении порядка назначения и выдачи лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения в филиалах ГБУЗ МО «МОКПТД» считать утратившими силу.

Главный врач С.В. Смердин

Приложение 1
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Инструкция о порядке получения, их учета, выдачи и списания лекарственных средств и медицинских изделий из аптеки ГБУЗ МО «МОКПТД»

2024 год.

Цель: Внутренний контроль качества и безопасности лечения пациентов.

Задачи: Нормирование запаса ЛС, расходных материалов, ИМН и дезинфицирующих средств в лечебных отделениях.

Область применения:

Где	Аптека. Отделения филиалов и клиник ГБУЗ МО «МОКПТД».
Когда	Постоянно.

1. **Старшие медицинские сестры филиалов, структурных отделений филиалов, структурных отделений Клиники 1, Клиники 2, стационара «Сукманиха» и медицинские сестры, ответственные за получение лекарственных средств и медицинских изделий:**

1.1. Требования - накладные (далее - ТН) в электронном виде в программе ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА подают в аптеку за два рабочих дня, до предполагаемой даты получения ЛС, ИМН, расходных материалов и ДС до 10-00 (для Клиники 1, стационара «Сукманиха» и Клиники 2). Филиалы предоставляют требования за 3 рабочих дня до предполагаемой даты получения до 10-00.

1.2. ТН на ЛС, подлежащие ПКУ, подаются в бумажном виде в двух экземплярах. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 № 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания". ТН на ЛС, подлежащие ПКУ составляется на латинском языке. Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, выписываются на отдельных бланках требований-накладных для каждой группы препаратов.

1.3. В требовании-накладной на ЛС, подлежащих ПКУ, указывается номер, дата составления документа, отправитель (аптека Клиники 1 или аптека стационара «Сукманиха») и получатель (старшая м/с отделения или старшая м/с филиала либо медицинские сестры, ответственные за получение лекарственных средств и расходных медицинских изделий), наименование лекарственного средства (с указанием дозировки, формы выпуска (таблетки, ампулы, мази, суппозитории и т.п.), вид упаковки (коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ применения (для инъекций, для наружного применения, приема внутрь, глазные капли и т.п.), количество затребованных лекарственных препаратов.

1.4. Требование - накладная на ЛС, подлежащие ПКУ, заверяется подписью заведующего отделением и заведующего филиалом/клиникой, ставится печать учреждения.

1.5. Электронная ТН составляется на основании данных ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА, в которой указывается источник финансирования (региональный, федеральный, собственные средства или спонсорская помощь). Каждый бюджет выписывается на отдельном требовании, также отдельно выписываются расходные материалы и дезинфицирующие средства, наркотические препараты, препараты предметно-количественного учета. Также в системе ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА можно просмотреть наименование, количество, срок годности каждого ЛС и расходного материала.

1.6. Старшие медицинские сестры филиалов, структурных отделений филиалов, структурных отделений Клиники 1, Клиники 2, стационара «Сукманиха» и медицинские сестры, ответственным за получение лекарственных препаратов и расходных медицинских изделий

получают в аптеке ЛС, расходные материалы, ИМН и дезинфицирующие средства лично, так как являются материально-ответственными лицами. Водителям по доверенности аптека не выдает ЛС, расходные материалы, ИМН и дезинфицирующие средства.

1.7. Старшие медицинские сестры филиалов, структурных отделений филиалов, структурных отделений Клиники 1, Клиники 2, стационара «Сукманиха» и медицинские сестры, ответственным за получение лекарственных препаратов и расходных медицинских изделий получают в аптеке ЛС, расходные материалы, ИМН и дезинфицирующие средства по утвержденному графику. Старшие медицинские сестры анестезиологореанимационных отделений могут получать ЛС, расходные материалы вне утвержденного графика по срочной потребности отделений. Получение ЛС по срочной потребности, при оформлении требований в системе ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА указывается высокий приоритет, и они отпускаются аптекой вне графика.

1.8. При получении из аптеки термолабильных ЛС и ИЛП необходимо использовать термоконтейнер для обеспечения соответствующих условий хранения при их транспортировке. Показания температурного режима при транспортировке термолабильных ЛС, МИ и ИЛП фиксировать в журнале учета транспортировки иммунобиологических лекарственных препаратов, термолабильных лекарственных средств (Приложение 30). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью и подписью главного врача ЛПУ.

1.9. При получении ЛС, ИМН, расходных материалов и дезинфицирующих средств старшая медицинская сестра отделения ставит подпись в ТН, сформированной на основании программы ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА. Данная ТН дальше передается в бухгалтерию. При поступлении ЛС, ИМН, расходных материалов и дезинфицирующих средств, старшая медицинская сестра обязана сверить фактически выданные товары с 1С ПТП (только противотуберкулезная терапия) и с программой ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА. Должно совпадать: номенклатура, дозировка, форма выпуска, количество полученного товара.

2. Аптека:

2.1. Отрабатывает ТН в течении 2 рабочих дней для стационаров Клиника 1, «Сукманиха» и Клиника 2. В течении 3-х рабочих дней для филиалов.

2.2. Оформляет противотуберкулезные препараты в двух программах (1С ПТП и ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА). В ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА оформляются требования, на все лекарственные препараты также включая и противотуберкулезную терапию, сопутствующие ЛС, расходные материалы, ИМН, дезинфицирующие средства. При исполнении ТН происходит синхронизация документов аптеки с документами отделений в системе ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА.

2.3. Выдает ЛС, расходные материалы, ИМН, дезинфицирующие средства по заявленным в ТН потребностям с учетом запасов. В отделения стационара «Сукманиха» и Клиники 1 не допускается выдача ЛС, расходных материалов, ИМН, дезинфицирующих средств в транспортных упаковках. Допускается выдача ЛС, расходных материалов, ИМН, дезинфицирующих средств в транспортных упаковках для филиалов ГБУЗ МО «МОКПТД» и Клиники 2. ЛС, расходные материалы, ИМН, дезинфицирующие средства освобождаются от транспортной упаковки перед их размещением для хранения в специальных помещениях филиалов и Клиники 2. Термолабильные ЛС и ИБП выдаются только при наличии термоконтейнера, для обеспечения соответствующих условий хранения при их транспортировке. Выдача товаров аптечного ассортимента в отделения производится в специально выделенной для этих целей зоне: зона выдачи.

2.4. В аптеке требования-накладные на отпуск наркотических средств и психотропных веществ списков II и III хранятся в течение 10 лет, на отпуск иных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, - в течение 3-х лет, остальных групп лекарственных препаратов - в течение одного календарного года (требования на остальные группы ЛС можно хранить в электронном виде с архивацией).

2.5. Требования-накладные на отпуск ЛС, подлежащих ПКУ должны храниться в аптеке в условиях, обеспечивающих сохранность, в сброшюрованном и опечатанном виде и оформляться в тома с указанием месяца и года. ТН на ЛС иных групп хранятся в электронном виде (архивированном).

3. Учет, выдача и списание ЛС:

3.1. В перечень ПКУ входят следующие группы лекарственных препаратов:

- лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV Перечня (далее – Перечень) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (далее – ЛП НС и ПВ и их прекурсоры);

- лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, внесенные в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (далее – ЛП СДВ и ЯВ);

- комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие фармакологические активные вещества, перечень которых утвержден разделом III Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н (далее – комбинированные ЛС ПКУ);

- иные лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету, перечень которых утвержден разделом IV Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 №183 н (далее – иные ЛС ПКУ);

3.2. Сведения о поступлении и выдачи препаратов, подлежащим ПКУ заносятся в журнал (приложение 23 - аптека), (приложение 26 - отделения) – кроме лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и включенных в списки II, III, IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и включенных в списки II, III, IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <2>, а также комбинированных лекарственных препаратов, которые содержат кроме наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологически активные вещества и в отношении которых в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" <3> предусмотрены меры контроля, аналогичные тем, которые установлены в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в них, осуществляется субъектами обращения лекарственных средств в специальных журналах по формам, предусмотренным приложением N 1 (ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ) к Правилам ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 N 2117.и приложением к Правилам ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 30.04.2022 N 809.

3.3. Лекарственные средства, подлежащие ПКУ подлежат учету по форме выпуска. В аптеке учет проводится в упаковках (форма журнала - Приложение 23), в отделениях - в таблетках, капсулах, ампулах и т.п (форма журнала - Приложение 26). Спирт этиловый подлежит учету и списанию. Учитывается и списывается во флаконах (канистрах), по форме выпуска. Этиловый спирт (этанол) – лекарственная форма: раствор для наружного применения. При учете и списании для текущей работы ФИО пациента не указывается. Единицей измерения следует считать ФЛАКОН или КАНИСТРА.

3.4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью и подписью главного врача ЛПУ. На первой странице журнала указываются лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, при этом на каждое наименование, фасовку, лекарственную форму, дозировку лекарственного средства открывается отдельная страница. Исправления зачеркиваются и заверяются подписью материально ответственного лица. Журналы учета оформляются на календарный год.

3.5. На последнее число каждого месяца старшая медицинская сестра или иное материально ответственное лицо, проводит сверку фактического наличия лекарственных средств с их остатком

по журналу учета и вносит соответствующие записи в журнал учета (для аптеки – форма журнала Приложение 23, гр. 12 – 14, для отделений – форма журнала Приложение 26, гр. 10 - 12).

3.6. Журнал учета хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, уполномоченного на ведение и хранение журнала учета.

3.7. В конце каждого месяца старшая медицинская сестра представляет в бухгалтерию ЛПУ отчет о движении лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих предметно-количественному учету, который утверждается руководителем ЛПУ.

3.8. Сведения о поступлении и выдачи препаратов Диаскин-тест, туберкулин регистрируются в журнале (приложение 24), крови и ее препаратов (приложение 25). Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью главного врача ЛПУ.

3.9. Старшие медицинские сестры выдают ЛС, расходные материалы, ИМН и дезинфицирующие средства для их использования (посты медицинских сестер, кабинеты выдачи ЛС пациентам на амбулаторном этапе лечения, процедурные, перевязочные кабинеты и т.п.) с запасом, не превышающим не более 3-х дней.

3.9. При перемещении ЛС и МИ из одного отделения в другое, подписание передачи происходит в системе «АС СМЕТА» с помощью электронных подписей материально-ответственных лиц передавших и получивших ЛС или МИ. В журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения делается соответствующая запись.

3.10. Медицинские сестры после назначения врачей выдают/вводят ЛС пациентам и ставят отметку ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА о выполнении назначения врача. Сведения о выдачи/введении препаратов пациентам, подлежащим ПКУ заносятся в журнал (приложение 26).

3.11. На основании выполненных назначений врача старшие медицинские сестры структурных подразделений Клиники 1, Клиники 2 и стационара «Сукманиха», старшие медицинские сестры филиалов и их структурных подразделений сверяют остатки ЛС на складе отделения и оформляют списание через систему ЕМИС МО. БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА ежедневно или по мере выдачи ЛС. При технических сбоях электронных систем и программ, уведомить отдел информационных технологий о наличии проблемы.

3.12 Старшие медицинские сестра ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным., в отдел по работе с первичными документами предоставляют отчет по утвержденной форме 2 - МЗ. (Приложение 29). К данному отчету должны быть приложены оборотные ведомости, в которых отражено движение лекарственных препаратов, расходных материалов, дезинфицирующих средств и ИМН с указанием остатка на начало месяца, приход, расход и остаток на конец месяца за подписью заведующего и материально ответственного лица.

3.12. Отчеты отделений служат основанием для составления Акта о списании материальных запасов и списания израсходованных лекарственных средств.

Приложение 2
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Инструкция по маркировке упаковок лекарственных средств.

2024 год.

Цель: Внутренний контроль качества и безопасности лечения пациентов.

Задачи: Маркировка на упаковки ЛС проводится для того, чтобы, заметив его, специалист аптеки или медсестра обратила внимание на вид препарата и внимательнее отнеслась к проверке названия и дозы, назначенного лекарства, во избежание ошибки при применении препарата.

Область применения:

Где	Аптека. Отделения ГБУЗ МО «МОКПТД», где осуществляется хранение лекарственных средств (далее – ЛС)
Когда	Постоянно

1. **Аптека:**

Маркировка упаковок ЛС производится путем размещения рядом с транспортной или потребительской упаковкой, не закрывая наименование ЛС, срока годности и серии:

Красный равносторонний треугольник 10х10х10см – маркируются:

Препараты особого контроля, превышение дозы которых может быть опасно. Возможно возникновение нежелательной реакции. Требуют медленного и осторожного введения

К препаратам данной категории относятся:
- растворы электролитов высокой плотности;
- препараты для химиотерапии;
- препараты для тромболизиса;
- инсулин для постоянной инфузии;
- наркотические препараты;
- сильнодействующие препараты;
- антикоагулянты (гепарин, фраксипарин, клексан).

Желтый равносторонний треугольник 10х10х10см маркируются:

Препараты, которые имеют очень похожие упаковки, разные дозировки, схожие названия, и их можно перепутать.

Зеленый равносторонний треугольник 10х10х10 см маркируются:
ЛС, срок годности которых скоро истекает (до истечения срока годности осталось 6 месяцев).

2. **Отделения:**

Маркировка упаковок ЛС производится путем наклеивания стикера на лицевую сторону потребительской упаковки в левый верхний угол. Стикеры должны быть прикреплены таким образом, чтобы не закрывать наименование, срок годности и серию ЛС.

Красный: Препараты особого контроля, превышение дозы которых может быть опасно. Возможно возникновение нежелательной реакции. Требуют медленного и осторожного введения.

Желтый: Препараты, которые имеют очень похожие упаковки, разные дозировки, схожие названия, и их можно перепутать.

Зеленый: ЛС, срок годности которых скоро истекает (до истечения срока годности осталось 3 месяца).

3. **Заместитель начальника по АХЧ:**

Осуществляет расчет потребности и подачу заявки на закупку стикеров для маркировки упаковок с ЛС.

Приложение 3
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в аптеке ГБУЗ МО «МОКПТД»»
(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)
2024 год.

1. Область применения:

Где	Материальные помещения аптеки, где осуществляется хранение запаса лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее – МИ)
Когда	Постоянно

2. Ответственность.
2.1. Руководитель организации:
- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛП.

2.2. Заведующая аптекой – провизор:
- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Провизоры-фармацевты:
- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП
3.1. Подготовительные операции:
Определить места хранения ЛС и МИ (шкафы для хранения ЛС или стеллажи):
- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22-24), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху или на внешнюю поверхность стеллажей:

ШКАФ № 1
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ШКАФ № 2 **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

ШКАФ № 3 **МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**

СТЕЛЛАЖ № 1 **МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- Пронумеровать полки шкафа и стеллажей (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.). Подписать полки шкафа/стеллажа шрифт «Times New Roman" №16-18, выделить жирным начертанием:

Полка №1
Полка №2

И т. д.

- Определить места на полках шкафов/стеллажей для хранения ЛС и МИ: промаркировать полки или шкафы: противотуберкулезные средства, гепатопротекторы, и т.п., согласно фармакологическому ряду препаратов и названию ИМН.

Определить оборудование для хранения термолабильных ЛС и ИБП, промаркировать холодильники:

• термолабильные ЛС с интервалом хранения от +2 до +8 °С – холодильник № __;

• термолабильные ЛС с интервалом хранения от +8 до + 15 °С – холодильник № ___;

• иммунобиологические препараты с интервалом хранения от +2 до + 8 °С – холодильник № ___;

4. Хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий.

4.1. Разместить ЛС и МИ по местам хранения (шкаф медицинский/стеллаж) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на заводской упаковке ЛС, а также с учетом фармакологической группы ЛС и определенным местам в шкафах/стеллажах.

4.2. Лекарственные препараты и медицинские изделия размещаются в транспортной или потребительской упаковке. Стеллажные карты размещаются рядом с упаковками ЛС, не закрывая название, срок годности и серию ЛС. Стеллажная карта распечатывается из программы ЕМИС МО БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА. Стеллажная карта должна содержать следующую информацию: (наименование ЛС, форма выпуска, дозировка, серия, срок годности, производитель). Размер стеллажной карты 60 х 80 мм. ПРИМЕР:

Собственные средства	
Дексаметазон-Ферейн, р-р д/ин., 4 мг/мл,2 мл, №25 - ампулы (25) - картонная пачка, От: АО БРЫНЦАЛОВ-А(РОССИЯ) [ДЕКСАМЕТАЗОН]	
Дата поставки	22.04.2024
Партия	PH-M0011143
Поставщик	ООО "Мартфарм"

Производитель	АО БРЫНЦАЛОВ-А
Серия	420322
Срок годности	01.03.2025

4.5. Шкафы с лекарственными препаратами должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным препаратам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность должна быть до 65%. Измерительные части гигрометров должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 - 1,7 м от пола.

5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.

5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельную тару (пластиковую корзину/контейнер). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.

5.4. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), каждой камеры холодильника: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и в конце смены фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (Приложение 27).

5.5. При использовании электронных термометров (гигрометров) с функцией автоматической выгрузкой и архивацией показателей микроклимата и температурного режима холодильного оборудования в личном кабинете сотрудника, проверка данных в личном кабинете производится ответственным лицом, ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

5.6. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 30 дней во время генеральных уборок, холодильников – 1 раз в 30 дней во время генеральных уборок, если другого не указано в рекомендациях производителя холодильного оборудования.

5.7. Контроль за сроками годности препаратов и ИМН проводить:

- при получении ЛС и МИ от поставщика;
- при выдаче препаратов старшим медицинским сестрам (материально ответственным лицам)
- во время генеральной уборки (1 раз в 30 дней).

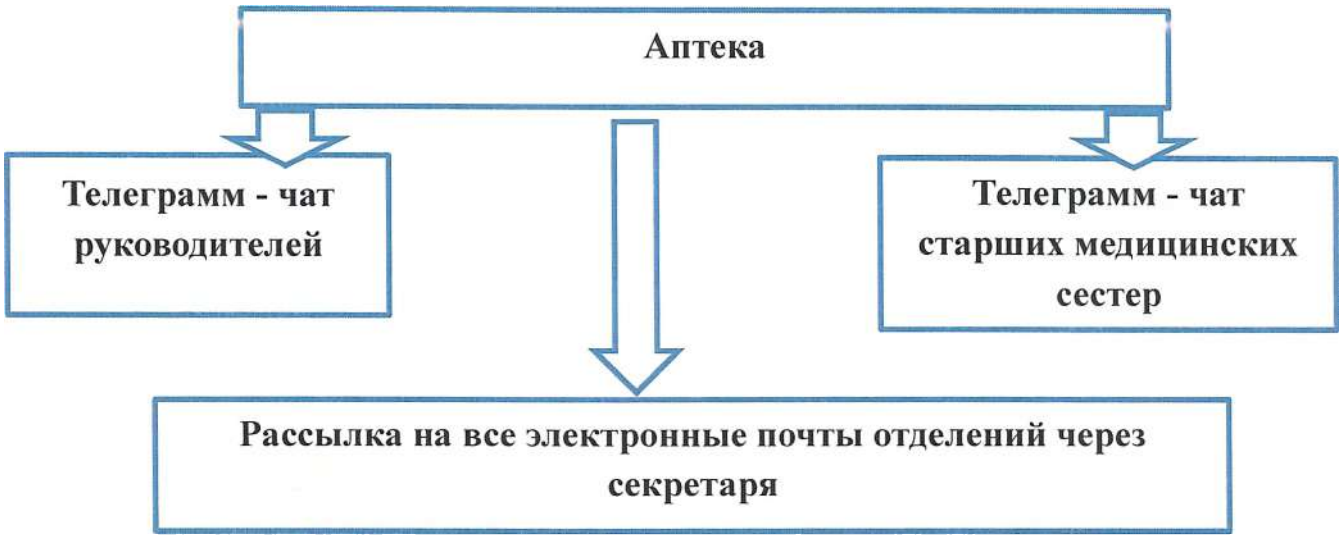
5.8. При выявлении ЛС с остаточным сроком годности шесть и менее месяцев, поставить в известность заведующего аптекой ГБУЗ МО «МОКПТД». Заведующий аптекой размещает информацию о количестве препаратов в телеграмм-чат старших медицинских сестер и врачей, а также сообщает заместителю главного врача по медицинской части.

5.9. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида, (йодоформ, перекись водорода, гидрокарбонат натрия); следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги).

5.10. Провизор-фармацевт в ежедневном режиме производит мониторирование официального сайта Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru на наличие информационных писем Росздравнадзора о приостановлении, прекращении обращения, отзыве из обращения ЛС, МИ. При выявлении ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в «карантинную зону».

5.11. Провизор-фармацевт информирует о наличии ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, заведующего аптекой. Заведующая аптекой передает информацию в телеграмм-чат старших медицинских сестер и врачей, а также секретарю для дальнейшей рассылки информации на электронные почты структурных подразделений ГБУЗ МО «МОКПТД»:

Информирование структурных подразделений об приостановке реализации ЛС или их изъятии



5.12 В аптеке организуются общие для ГБУЗ МО «МОКПТД» карантинные зоны:

- **Зона карантинного хранения:** приостановка обращения; несоответствие товарно-сопроводительной документации; сомнение в подлинности или качестве. В данной зоне необходимо поддержание условий хранения ЛС и МИ. ЛС без особых условий хранения – в обычных помещения или зонах хранения – выделяется отдельный шкаф или полка; термолабильные в холодильниках – выделяется отдельные холодильник или полка, иммунобиологические в холодильниках для ИЛП – выделяется отдельные холодильник или полка; подлежащие ПКУ в специальных шкафах или сейфах – выделяется отдельный шкаф/сейф или полка. При решении Росздравнадзора о возвращении в оборот данных ЛС и МИ, они выдаются в отделения, при решении о прекращении использования перемещаются в зону изъятых из обращения ЛС и МИ с дальнейшей их утилизацией или возврату Поставщику.

Данная зона должна иметь маркировку (шрифт Times New Roman, Размер шрифта: оглавление 24, выделено жирным текстом, текст – 16). Размер маркировки 15х7 см.

Зона карантинного хранения
- приостановка обращения ЛС;
- несоответствие товарно-сопроводительной документации;
- сомнения в подлинности и качестве.

- **Зона изъятых из обращения ЛС и МИ:** - фальсифицированные, некачественные, контрафактные, с истекшим сроком годности ЛС и МИ. Данная зона не требует специальных условий хранения. Для этой зоны выделяется отдельный контейнер/шкаф/полка/стеллаж. ЛС, ДС

из этой зоны передаются для их утилизации, как отходы класса Г по договору со специализированной организацией, а МИ подлежат утилизации, как отходы класса Б.
Данная зона должна иметь маркировку (шрифт Times New Roman, Размер шрифта: оглавление 24, выделено жирным текстом, текст – 16). Размер маркировки 15х7 см.

Карантинная зона для ЛС, изъятых из обращения

- фальсифицированные;
- недоброкачественные;
- контрафактные;
- с истекшим сроком годности.

5.13. Располагать лекарственные средства и медицинские изделия внутри шкафа и на стеллажах необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса. Лекарственные средства хранятся в потребительской или транспортной упаковке и размещаются этикеткой (маркировкой) наружу.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеке:

6.1. Помещение должно быть оснащено в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС при их хранении.

6.2. Помещения оснащаются шкафами, стеллажами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.

6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.

6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.

6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

6.7. Помещения для хранения ЛС и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.

6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛС и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже 1 раза в 30 дней.

6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

Приложение 4
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий на постах медицинских сестер стационарных отделений»
(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)
2024 год.

1. Область применения:

Где	Посты медицинских сестер стационарных отделений ГБУЗ МО «МОКПТД», где осуществляется хранение лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее МИ)
Когда	Постоянно

2. Ответственность:
2.1. Руководитель организации:
- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛП.

2.2. Заведующая аптекой – провизор, главная медицинская сестра:
- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Старшие медицинские сестры клиник и филиалов, имеющем в структуре стационарные отделения:
- за наличие в клиниках и филиалах и в их структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;
- за сохранность и правильность хранения лекарственных средств и расходных медицинских изделий на постах медицинских сестер стационарных подразделений клиники/филиала.

2.4. Старшие медицинские сестры стационарных отделений:
- за организацию условий хранения ЛС и МИ на постах медицинских сестер

2.5. Медицинские сестры палатные:
- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП
3.1. Подготовительные операции:
Определить места хранения ЛС и МИ (шкаф для хранения ЛС и МИ):

- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху:

ШКАФ № 1 **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

- Пронумеровать полки шкафа (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.).
Подписать полки шкафа шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

Полка №1
Полка №2

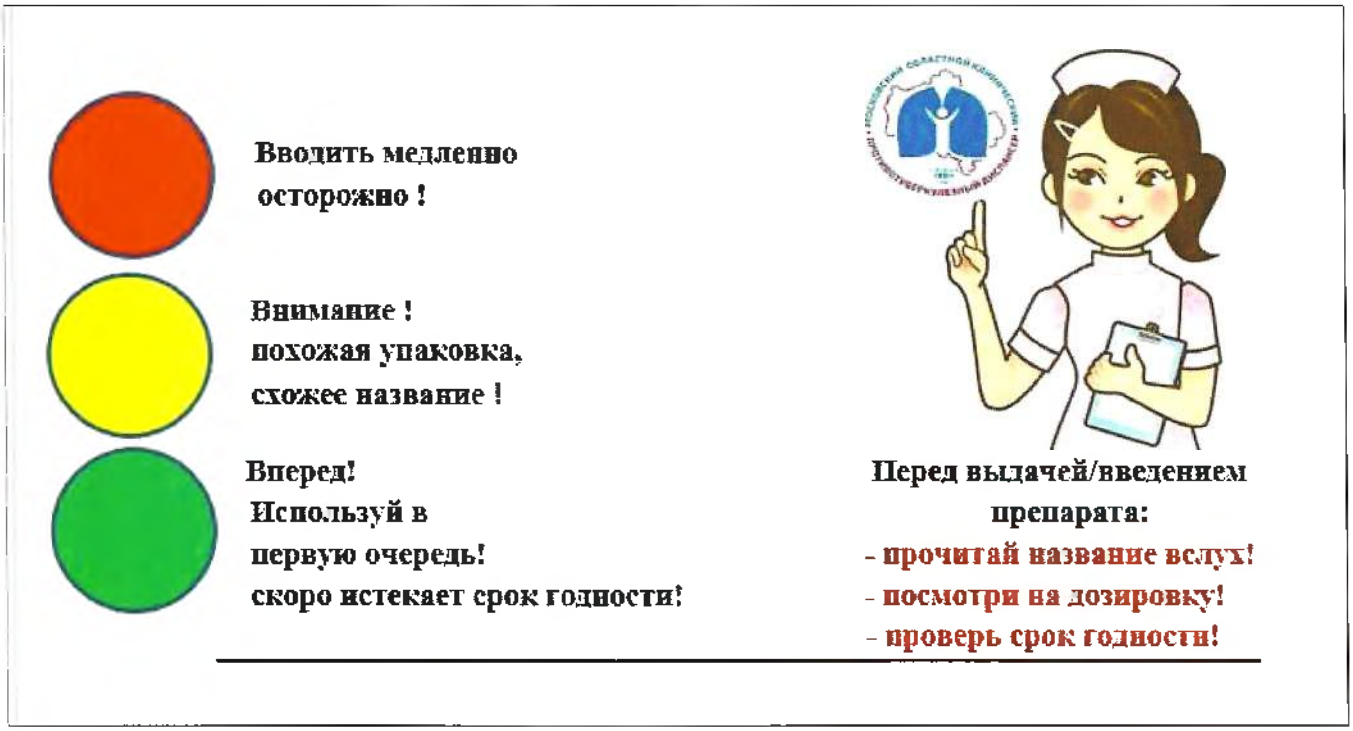
И т. д.

- Определить места на полках шкафа для хранения ЛП:
· полка № 1 слева – АРВТ (при наличии данных ЛС);
• полка № 1 справа – сильнодействующие средства:
• полка № 2 – противотуберкулезные препараты;
• полка № 3 – внутренние препараты;
• полка № 4 – наружные препараты;
• полка № 5 – медицинские изделия;
• термолабильных с интервалом хранения от +2 до +8 °С – холодильник № __;
• термолабильных с интервалом хранения от +8 до + 15 °С – холодильник № ___.
Примечание: если конструкция шкафа имеет отдельный бокс (сейф) с ключом, то сильнодействующие препараты необходимо хранить в этом боксе (сейфе). Если посты медицинских сестер не оборудованы холодильниками, то при наличии термолабильных ЛС допустимо их хранение в холодильниках процедурного кабинета, с соответствующим температурным режимом. ЛС помещаются в отдельный контейнер (сетчатую корзину), контейнер маркируется: пост, наименование ЛС.

4. Хранение лекарственных препаратов
4.1. Разместить ЛС и МИ по местам хранения (шкаф медицинский) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке ЛС и определенным местам в шкафу.
4.2. Лекарственные средства и медицинские изделия размещаются в потребительской упаковке. Допускается размещение препаратов в потребительских упаковках в специальных пластиковых контейнерах. На контейнеры прикрепляются этикетки с наименованием фармакологического ряда размещенных в них препаратов (пример: противотуберкулезные препараты, желудочно-кишечные, гипотензивные, витамины и т.п.). При отсутствии контейнеров, препараты размещаются непосредственно на полках шкафа. В этом случае этикетки с наименованием фармакологического ряда препаратов прикрепляются непосредственно на внутреннюю поверхность стены шкафа или в другое место непосредственно на полку. Для этикеток использовать шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:
4.3. На внутренней левой дверце шкафа на уровне глаз размещается список препаратов, находящихся в шкафу. Список печатается по названию препарата в алфавитном порядке:
Шрифт №14:
Надпись «СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №___»
Шрифт №12 Наименование граф в таблице;
Шрифт №12 в самой таблице

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф № ___			
Наименование лекарственного препарата, дозировка, форма выпуска	**Номер полки**	**Высшая разовая Доза (только для сильнодействующих препаратов)**	**Высшая суточная Доза (только для сильнодействующих препаратов)**

4.4. На внутреннюю поверхность правой дверцы шкафа (ровно в середине на уровне глаз) прикрепляется памятка о маркировке упаковок с лекарственными препаратами. Размер А5 (14,8х21 см.). Ниже указанной памятки, прикрепляется памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (приложение 21). Данные памятки должны быть заламинированы.



4.5. Шкафы с лекарственными средствами должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным средствам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность должна быть до 65%. Измерительные части гигрометров должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 - 1,7 м от пола.
5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.
5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельную тару (пластиковую корзину/контейнер). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.
5.4. Разместить автономные термометры в холодильники (при наличии оборудования), согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), **каждой камеры холодильника**: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и 20-00 фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).
5.5. Если в холодильнике (+2 °С до +8 °С) температура ниже +2 °С или выше +8 °С, а в холодильнике (+8 до + 15 °С) ниже +8 °С или выше + 15 °С, попытаться отрегулировать холодильник, через 1 час проверить. Если температура не поднялась или опустилась до положенной, отключить холодильник. Переместить ЛП в резервный холодильник или в термоконтейнер с хладоэлементами. Поставить в известность старшую медицинскую сестру.
5.6. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 7 дней во время генеральных уборок.
5.7. Контроль за сроками годности препаратов проводить:
- при получении препаратов у старшей медицинской сестры;
- перед выдачей препарата пациенту;
- во время генеральной уборки (1 раз в 7 дней).
5.8. При выявлении ЛС с остаточным сроком годности меньше трех месяцев, промаркировать упаковку с препаратом (зеленый стикер) поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения.
5.9. При выявлении ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в соответствующие **«карантинные зоны» у старшей медицинской сестры отделения.**
5.10. Располагать лекарственные средства и медицинские изделия внутри шкафа необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных препаратов на постах медицинских сестер.

6.1. Помещение (посты) должно быть оснащено в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС и МИ при их хранении.
6.2. Помещения оснащаются шкафами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.

6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.
6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.
6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.
6.7. Помещения для хранения ЛС и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.
6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛС и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже 1 раз в 7 дней.
6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

Приложение 5
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в процедурных, перевязочных кабинетах, кабинетах врачей-специалистов и реанимационных залах стационарных отделений»

(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)

2024 год.

1. Область применения:

Где	Процедурные и перевязочные кабинеты, реанимационные залы, кабинеты врачей-специалистов стационарных отделений ГБУЗ МО «МОКПТД», где осуществляется хранение лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее МИ).
Когда	Постоянно

2. Ответственность.

2.1. Руководитель организации:

- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛС и МИ.

2.2. Заведующая аптекой – провизор, главная медицинская сестра:

- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Старшие медицинские сестры клиник и филиалов, имеющем в структуре стационарные отделения:

- за наличие в клиниках и филиалах и в их структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;
- за сохранность и правильность хранения лекарственных средств и расходных медицинских изделий в процедурных и перевязочных кабинетах, реанимационных залах, кабинетах врачей-специалистов стационарных подразделений клиники/филиала.

2.4. Старшие медицинские сестры стационарных отделений:

- за организацию условий хранения ЛС в процедурных и перевязочных кабинетах, реанимационных залах, кабинетах врачей-специалистов отделений.

2.5. Медицинские сестры процедурные, перевязочные, медицинские сестры-анестезистки, медицинские сестры врачей -специалистов:

- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП

3.1. Подготовительные операции:

Определить места хранения ЛС и МИ (шкаф для хранения ЛС и МИ):

- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху:

ШКАФ № 1 **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

ШКАФ № 2 **РАСТВОРЫ**

ШКАФ № 3 **МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, УКДАДКИ**

- Пронумеровать полки шкафа (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.).

Подписать полки шкафа шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

Полка №1
Полка №2

И т. д.

- Определить места на полках шкафа №1 для хранения ЛС: промаркировать полки, согласно фармакологическому ряду препаратов или способов введения препаратов.
- Определить места на полках шкафа №2 для хранения растворов: промаркировать полки, согласно наименованию растворов.
- Определить места на полках шкафа №3 для хранения МИ и укладок: промаркировать полки, согласно наименованию МИ и укладок. Не допускать хранение стерильных ИМН на нижней полке шкафа.

Допускается хранение МИ и укладок на отдельных полках шкафов совместно с ЛС или растворами при отсутствии отдельного шкафа.

Промаркировать холодильники:

• термолабильные ЛС с интервалом хранения от +2 до +8 °С – холодильник № 1

• термолабильные ЛС с интервалом хранения от +8 до + 15 °С – холодильник № 2.

4. Хранение лекарственных препаратов

4.1. Разместить ЛС по местам хранения (шкаф медицинский) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке ЛС и определенным местам в шкафах.

4.2. Лекарственные средства и медицинские изделия размещаются в потребительской упаковке. Допускается размещение препаратов в потребительских упаковках в специальных пластиковых контейнерах (сетчатых корзинах). На контейнеры прикрепляются этикетки с наименованием фармакологического ряда размещенных в них препаратов (пример: противотуберкулезные препараты, антибиотики и т.п.). При отсутствии контейнеров, ЛС размещаются непосредственно на полках шкафа. В этом случае этикетки с наименованием фармакологического ряда препаратов

прикрепляются непосредственно на внутреннюю поверхность стены шкафа или в другое место непосредственно на полку. Для этикеток использовать шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

4.3. На внутренней левой дверце шкафа на уровне глаз размещается список препаратов, находящихся в шкафу. Список печатается по названию препарата в алфавитном порядке:

Шрифт №14:

Надпись «СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №___»

Шрифт №12 Наименование граф в таблице;

Шрифт №12 в самой таблице:

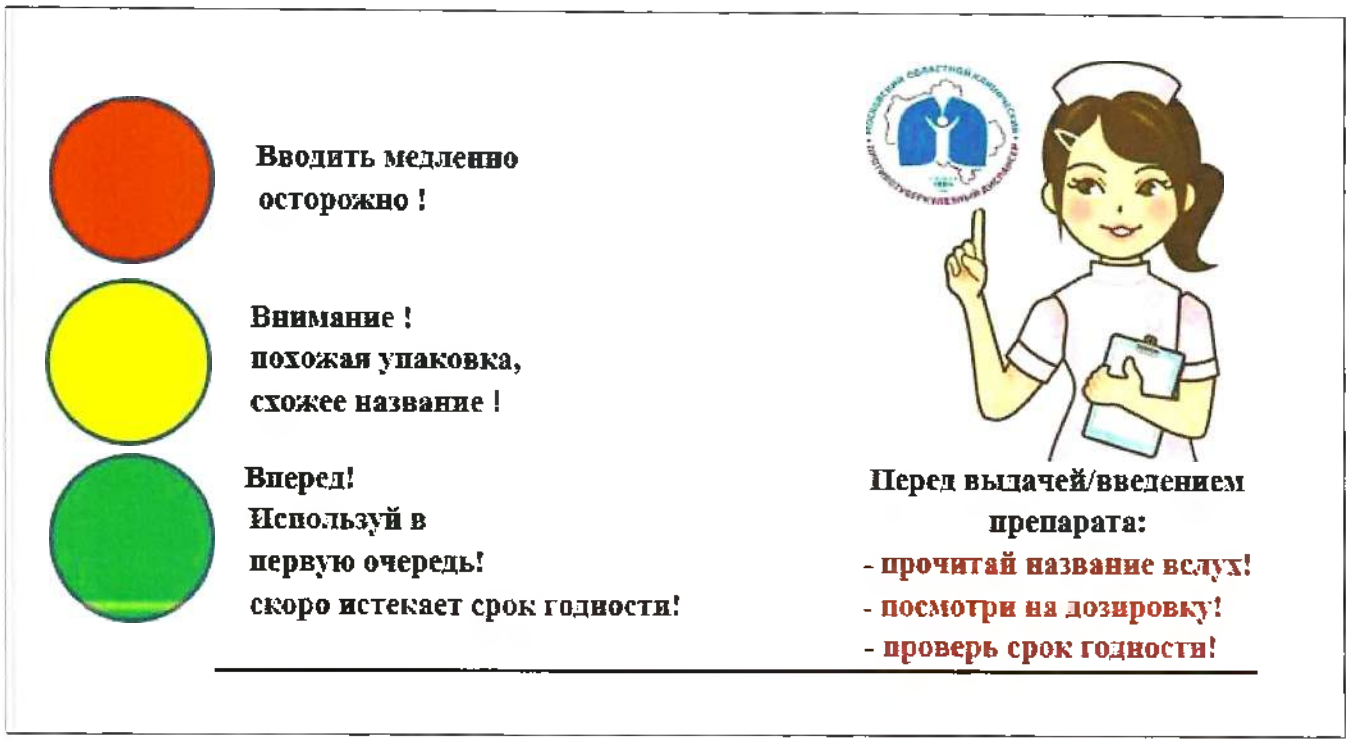
СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №			
Наименование лекарственного средства, дозировка, форма выпуска	**Номер полки**	**Высшая разовая доза (для сильнодействующих ЛС)**	**Высшая суточная доза (для сильнодействующих ЛС)**

Укладки неотложной помощи хранятся в опечатанном виде. При опечатывании ставится дата предполагаемого вскрытия и подпись старшей медицинской сестры филиала/отделения на опечатывающий стикер. Предполагаемая дата вскрытия укладок – 3 месяца до истечения срока годности препарата или МИ. На внешней стороне укладки прикрепляется список ЛС и МИ:

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ укладка			
Наименование лекарственного средства, дозировка. Наименование МИ	**форма выпуска**	**серия**	**Срок годности**

Первый истекающий срок годности выделяется маркером. Упаковки ЛП в укладках должны быть промаркированы в соответствии с приложением № 2 настоящего приказа «Инструкция по маркировке упаковок лекарственных препаратов».

4.4. На внутреннюю поверхность правой дверцы шкафа (ровно в середине, на уровне глаз) прикрепляется памятка о маркировке упаковок с лекарственными препаратами. Размер А5 (14,8х21 см.). Ниже указанной памятки, прикрепляется памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (приложение 21). Данные памятки должны быть заламинированы.



4.5. Шкафы с лекарственными препаратами должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным препаратам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность должна быть до 65%. Измерительные части гигрометров должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 - 1,7 м от пола.

5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.

5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельные тары (пластиковые корзины/контейнеры). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.

5.4. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), **каждой камеры холодильника**: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и 20-00 фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).5.4. Если в холодильнике (+2 °С до +8 °С) температура ниже +2 °С или выше +8 °С, а в холодильнике (+8 до + 15 °С) ниже +8 °С или выше + 15 °С, попытаться отрегулировать холодильник, через 1 час проверить. Если температура не поднялась или опустилась до положенной, отключить холодильник. Переместить ЛС в резервный холодильник или в термоконтейнер с хладоэлементами. Поставить в известность старшую медицинскую сестру.

5.5. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 7 дней во время генеральных уборок, холодильников 1 раз в 7 дней, во время генеральных уборок, если это не противоречит рекомендациям производителя холодильного оборудования.
5.6. Контроль за сроками годности ЛС и МИ проводить:
- при получении препаратов у старшей медицинской сестры;
- перед введением препарата пациенту;
- во время генеральной уборки (1 раз в 7 дней).
5.7. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида, (йодоформ, перекись водорода, гидрокарбонат натрия); следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги).
5.8. При выявлении ЛС с остаточным сроком годности меньше трех месяцев, нанести маркировку на упаковку с препаратом (зеленый стикер), поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения.
5.9. При выявлении ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в соответствующую **«карантинную зону» у старшей медицинской сестры отделения.**
5.11. Располагать лекарственные средства и медицинские изделия внутри шкафа необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных препаратов в процедурных, перевязочных кабинетах, кабинетах врачей-специалистов и реанимационных залах стационарных отделений

6.1. Помещения (процедурные, перевязочные, кабинеты) должно быть оснащены в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС при их хранении.
6.2. Помещения оснащаются шкафами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.
6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.
6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.
6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.
6.7. Помещения для хранения ЛС и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.
6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛС и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже, чем каждые 7 дней.
6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

Приложение 6
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)
«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий у старших медицинских сестер стационарных отделений»
(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)
2024 год.

1. Область применения:

Где	Кабинеты, где осуществляется хранение запаса лекарственных средств (далее – ЛС) и МИ (далее – медицинских изделий)
Когда	Постоянно

2. Ответственность.
2.1. Руководитель организации:
- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛП.

2.2. Заведующая аптекой – провизор, главная медицинская сестра:
- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Старшие медицинские сестры клиник и филиалов, имеющем в структуре стационарные отделения:
- за наличие в клиниках и филиалах и в их структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;
- за организацию условий хранения ЛС у старших медицинских сестер стационарных подразделений;
- за сохранность и правильность хранения лекарственных средств и расходных медицинских изделий в кабинетах, где осуществляется хранение лекарственных средств.

2.4. Старшие медицинские сестры стационарных отделений:
- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП
3.1. Подготовительные операции:
Определить места хранения ЛС и МИ (шкафы для хранения ЛС и МИ или стеллажи):

- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху или на внешнюю поверхность стеллажей:

ШКАФ № 1 **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

ШКАФ № 2 **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

ШКАФ № 3 **МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**

СТЕЛЛАЖ № 1 **МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- Пронумеровать полки шкафа и стеллажей (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.). Подписать полки шкафа/стеллажа шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

Полка №1
Полка №2

И т. д.

- Определить места на полках шкафов/стеллажей для хранения ЛС и МИ: промаркировать полки, согласно фармакологическому ряду ЛС и названию МИ:
• шкаф № 1 верхняя полка – АРВТ средства (при наличии данных ЛС);
• шкаф № 1 полка № 2 - № 4 – противотуберкулезные препараты;
• шкаф № 2 полка № 1, № 2 – внутренние средства;
• шкаф № 2 полка № 3, № 4 – наружные средства;
• шкаф № 3 - растворы;
• стеллаж № 1 – медицинские изделия;
• сейф – сильнодействующие средства.
Промаркировать холодильники:
• термолабильные ЛС с интервалом хранения от +2 до +8 °С – холодильник № 1;
• термолабильные ЛС с интервалом хранения от +8 до + 15 °С – холодильник № 2.

4. Хранение лекарственных средств:

4.1. Разместить ЛС и МИ по местам хранения (шкаф медицинский/стеллаж) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке ЛС и определенным местам в шкафах/стеллажах.

4.2. Лекарственные препараты и медицинские изделия размещаются в потребительской упаковке. Не допускается хранение ЛС и МИ в транспортных упаковках. Допускается размещение препаратов в потребительских упаковках в специальных пластиковых контейнерах (сетчатых корзинах). На контейнеры прикрепляются этикетки с наименованием фармакологического ряда

размещенных в них препаратов (пример: противотуберкулезные препараты, антибиотики и т.п.). При отсутствии контейнеров, ЛС размещаются непосредственно на полках шкафа. В этом случае этикетки с наименованием фармакологического ряда препаратов прикрепляются непосредственно на внутреннюю поверхность стены шкафа или в другое место непосредственно на полку. Для этикеток использовать шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием. Стеллажные карты размещаются рядом с упаковками ЛС, не закрывая название, срок годности и серию ЛС. Стеллажная карта распечатывается из программы ЕМИС МО БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА. Стеллажная карта должна содержать следующую информацию: (наименование ЛП, форма выпуска, дозировка, серия, срок годности, производитель). Размер стеллажной карты 60 х 80 мм. ПРИМЕР:

Собственные средства	
Дексаметазон-Ферейн, р-р д/инф., 4 мг/мл,2 мл, №25 - ампулы (25) - картонная пачка. От: АО БРЫНЦАЛОВ-А(РОССИЯ) [ДЕКСАМЕТАЗОН]	
Дата поставки	22.04.2024
Партия	РН-М0011143
Поставщик	ООО "Мартфарм"
Производитель	АО БРЫНЦАЛОВ-А
Серия	420322
Срок годности	01.03.2025

4.3. На внутренней левой дверце шкафа размещается список препаратов, находящихся в шкафу.
Шрифт №14: **Надпись «СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №___»**
Шрифт №12 Наименование граф в таблице;
Шрифт №12 в самой таблице: (список постоянно актуализируется)

Номер полки	**Наименование лекарственного средства, дозировка**	**форма выпуска**	**Срок годности**	**Высшая разовая доза (для сильнодействующих ЛС)**	**Высшая суточная доза (для сильнодействующих ЛС)**
№ 1					
№ 1					
№ 1					
№ 1					
№ 2					
№ 2					
№ 2					
№ 3					
№ 3					
№ 3					

4.4. На внутреннюю поверхность правой дверцы шкафа (ровно в середине на уровне глаз) прикрепляется памятка о маркировке упаковок с лекарственными препаратами. РазмеА5(14,8х21). Ниже указанной памятки, прикрепляется памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (приложение 21). Данные памятки должны быть заламинированы.

4.5. Шкафы с лекарственными препаратами должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным препаратам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность - до 65%.

5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.

5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельную тару (пластиковую корзину/контейнер). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.

5.4. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), **каждой камеры холодильника**: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и в конце рабочей смены. Показания фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).

5.5. Если в холодильнике (+2 °С до +8 °С) температура ниже +2 °С или выше +8 °С, а в холодильнике (+8 до + 15 °С) ниже +8 °С или выше + 15 °С, попытаться отрегулировать холодильник, через 1 час проверить. Если температура не поднялась или опустилась до положенной, отключить холодильник. Переместить ЛП в резервный холодильник или в термоконтейнер с хладоэлементами. Поставить в известность заведующего отделением и специалиста по медицинской техники отдела АХО. Записать в журнал нежелательных событий. Сформировать заявку на ремонт оборудования.

5.6. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 7 дней во время генеральных уборок, холодильников 1 раз в 7 дней, во время генеральных уборок, если это не противоречит рекомендациям производителя холодильного оборудования.
5.7. Контроль за сроками годности ЛС и МИ проводить:
- при получении ЛС и МИ из аптеки;
- при выдаче ЛС и МИ на посты, в процедурные и т.п.;
- во время генеральной уборки (1 раз в 7 дней).
5.8. При выявлении ЛС и МИ с остаточным сроком годности меньше трех месяцев, поставить в известность заведующего отделением и заведующую аптекой ГБУЗ МО «МОКПТ». Разместить информацию о количестве препаратов в телеграмм-чат.
5.9. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида, (йодоформ, перекись водорода, гидрокарбонат натрия); следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги).
5.10. Информацию о наличии ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, старшие медицинские сестры получают через сообщения в телеграмм-чатах «Мониторинг лекарственных средств», «Старшие медицинские сестры» или из писем на электронные почты отделений. Старшие медицинские сестры обязаны проводить мониторинг данных чатов и почты не реже 3 раз в день. При выявлении ЛС и МИ (в кабинете основного запаса, процедурных, перевязочных кабинетах, постах медицинских сестер), в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в «карантинную зону».
- **Зона карантинного хранения:** приостановка обращения; несоответствие товарно-сопроводительной документации; сомнение в подлинности или качестве. В данной зоне необходимо поддержание условий хранения ЛС и МИ. ЛС без особых условий хранения – в обычных помещения или зонах хранения – выделяется отдельный шкаф или полка; термолабильные в холодильниках – выделяется отдельные холодильник или полка, иммунобиологические в холодильниках для ИЛП – выделяется отдельные холодильник или полка; подлежащие ПКУ в специальных шкафах или сейфах – выделяется отдельный шкаф/сейф или полка. При решении Росздравнадзора о возвращении в оборот данных ЛС и МИ, они выдаются в отделения, при решении о прекращении использования перемещаются в зону изъятых из обращения ЛС и МИ с дальнейшей их утилизацией или возврату Поставщику.
Данная зона должна иметь маркировку (шрифт Times New Roman, Размер шрифта: оглавление 24, выделено жирным текстом, текст – 16). Размер маркировки 15х7 см.

Зона карантинного хранения
- приостановка обращения ЛС;
- несоответствие товарно-сопроводительной документации;
- сомнения в подлинности и качестве.

- **Зона изъятых из обращения ЛС и МИ:** - фальсифицированные, некачественные, контрафактные, с истекшим сроком годности ЛС и МИ. Данная зона не требует специальных условий хранения. Для этой зоны выделяется отдельный контейнер/шкаф/полка/стеллаж. ЛС, ДС из этой зоны передаются для их утилизации, как отходы класса Г по договору со специализированной организацией, а МИ подлежат утилизации, как отходы класса Б.
Данная зона должна иметь маркировку (шрифт Times New Roman, Размер шрифта: оглавление 24, выделено жирным текстом, текст – 16). Размер маркировки 15х7 см.

Карантинная зона для ЛС, изъятых из обращения

- фальсифицированные;
- недоброкачественные;
- контрафактные;
- с истекшим сроком годности.

5.13. Располагать лекарственные препараты и медицинские изделия внутри шкафа и на стеллажах необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса. Лекарственные препараты хранятся в потребительской упаковке и размещаются этикеткой (маркировкой) наружу.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных препаратов у старших медицинских сестер стационарных отделений:

6.1. Помещение должно быть оснащено в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС при их хранении.

6.2. Помещения оснащаются шкафами, стеллажами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.

6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.

6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.

6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

6.7. Помещения для хранения ЛП и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.

6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛС и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже 1 раза в 7 дней.

6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

6.10. В помещении должна быть выделена зона приемки ЛС из аптеки (стол, кушетка). Зона приемки должна быть предназначена для сортировки поступивших ЛС и МИ из аптеки ГБУЗ МО «МОКПТД»

Приложение 7
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в кабинетах выдачи пациентам лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения»

(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)

2024 год.

1. Область применения:

Где	Кабинеты выдачи пациентам лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения, где осуществляется хранение лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее МИ).
Когда	Постоянно

2. Ответственность.

2.1. Руководитель организации:

- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛП.

2.2. Заведующая аптекой – провизор, главная медицинская сестра:

- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Старшие медицинские сестры филиалов, имеющем в структуре амбулаторные отделения:

- за наличие в филиалах и в их структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;
- за сохранность и правильность хранения лекарственных средств и расходных медицинских изделий в кабинетах выдачи пациентам лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения.

2.4. Старшие медицинские сестры амбулаторных отделений:

- за организацию условий хранения ЛС и МИ в кабинетах выдачи пациентам лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения

2.5. Медицинские сестры амбулаторных отделений (процедурные, участковые):

- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП

3.1. Подготовительные операции:

Определить места хранения ЛС и МИ (шкаф для хранения ЛП и МИ):

- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху:

ШКАФ № 1
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- Пронумеровать полки шкафа (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.).

Подписать полки шкафа шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

Полка №1

Полка №2

И т. д.

- Определить места на полках шкафа для хранения ЛП:

• полка № 1 – противотуберкулезные препараты;
• полка № 2 – противотуберкулезные препараты;
• полка № 3 – внутренние препараты;
• полка № 4 (отдельный отсек шкафа – при наличии) – медицинские изделия;
• термолабильных с интервалом хранения от +2 до +8 °С – холодильник № __;
• термолабильных с интервалом хранения от +8 до + 15 °С – холодильник № ___.

Примечание: <u>если кабинеты выдачи ЛС не оборудованы холодильниками, то при наличии термолабильных ЛС допустимо их хранение в холодильниках процедурного кабинета, с соответствующим температурным режимом. ЛС помещаются в отдельный контейнер (сетчатую корзину), контейнер маркируется: кабинет, наименование ЛС.</u>

4. Хранение лекарственных препаратов

4.1. Разместить ЛС по местам хранения (шкаф медицинский) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке ЛС и определенным местам в шкафу.

4.2. Лекарственные препараты и медицинские изделия размещаются в потребительской упаковке. Допускается размещение препаратов в потребительских упаковках в специальных пластмассовых контейнерах. На контейнеры прикрепляются этикетки с наименованием препаратов, размещенных в них. При отсутствии контейнеров, препараты размещаются непосредственно на полках шкафа. В этом случае этикетки с наименованием препаратов прикрепляются непосредственно на внутреннюю поверхность стены шкафа или в другое место непосредственно на полку. Для этикеток использовать шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

4.3. На внутренней левой дверце шкафа на уровне глаз размещается список препаратов, находящихся в шкафу. Список печатается по названию препарата в алфавитном порядке:

Шрифт №14:

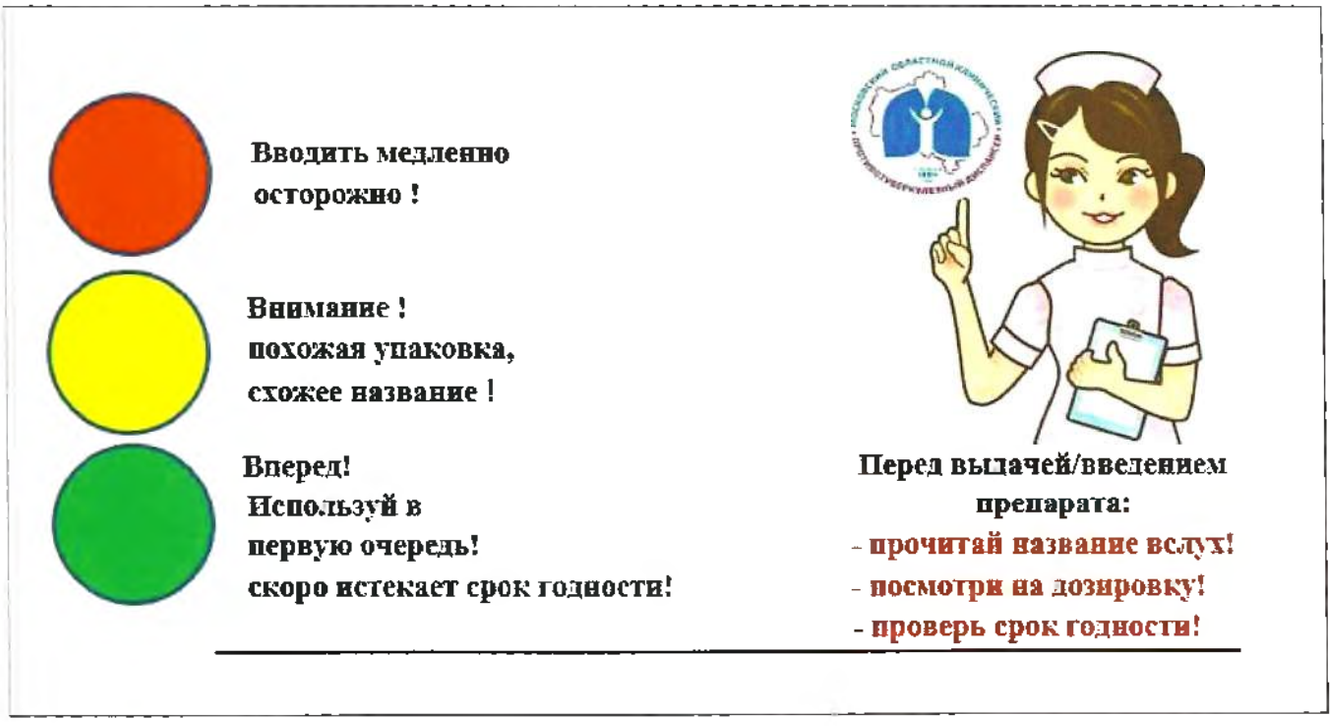
Надпись «СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №___»

Шрифт №12 Наименование граф в таблице;

Шрифт №12 в самой таблице

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №			
Номер полки	**Наименование лекарственного препарата, дозировка, форма выпуска**	**серия**	**Срок годности**

4.4. На внутреннюю поверхность правой дверцы шкафа (ровно в середине на уровне глаз) прикрепляется памятка о маркировке упаковок с лекарственными препаратами. Размер А5 (14,8х21 см.). Ниже указанной памятки, прикрепляется памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (приложение 21). Данные памятки должны быть заламинированы.



4.5. Шкафы с лекарственными средствами и медицинскими изделиями должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным препаратам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность должна быть до 65%. Измерительные части гигрометров должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов.

Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 - 1,7 м от пола.
5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.
5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельную тару (пластиковую корзину/контейнер). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.
5.4. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), **каждой камеры холодильника**: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и 20-00 фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).
5.5. Если в холодильнике (+2 °С до +8 °С) температура ниже +2 °С или выше +8 °С, а в холодильнике (+8 до + 15 °С) ниже +8 °С или выше + 15 °С, попытаться отрегулировать холодильник, через 1 час проверить. Если температура не поднялась или опустилась до положенной, отключить холодильник. Переместить ЛС в резервный холодильник или в термоконтейнер с хладоэлементами. Поставить в известность старшую медицинскую сестру.
5.6. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 7 дней во время генеральных уборок, холодильников 1 раз в 7 дней, во время генеральных уборок, если это не противоречит рекомендациям производителя холодильного оборудования
5.7. Контроль за сроками годности препаратов проводить:
- при получении препаратов у старшей медицинской сестры;
- перед выдачей препарата пациенту;
- во время генеральной уборки (1 раз в 7 дней).
5.8. При выявлении ЛС с остаточным сроком годности 3 месяца и меньше, наклеить на упаковку зеленый стикер, поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения.
5.9. При выявлении ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в соответствующую **«карантинную зону» у старшей медицинской сестры отделения.**
5.10. Располагать лекарственные средства и медицинские изделия внутри шкафа необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных препаратов в кабинетах выдачи пациентам лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения.

6.1. Помещение должно быть оснащено в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС при их хранении.
6.2. Помещения оснащаются шкафами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.
6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.

6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.
6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.
6.7. Помещения для хранения ЛС и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.
6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛС и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже 1 раза в 7 дней.
6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

Приложение 8
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий в процедурных кабинетах филиалов и их структурных подразделений, осуществляющий амбулаторный этап лечения пациентов и в приемных отделениях стационаров»

(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)

2024 год.

1. Область применения:

Где	Процедурные кабинеты филиалов и их структурных подразделений, осуществляющий амбулаторный этап лечения пациентов, где осуществляется хранение лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее - МИ), приемные отделения стационаров.
Когда	Постоянно

2. Ответственность.

2.1. Руководитель организации:

- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛП.

2.2. Заведующая аптекой – провизор, главная медицинская сестра:

- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Старшие медицинские сестры филиалов, клиник и их структурных подразделений:

- за наличие в клиниках и филиалах и в их структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;
- за сохранность и правильность хранения лекарственных средств и медицинских изделий в процедурных кабинетах.
- за организацию условий хранения ЛС в процедурных кабинетах и приемных отделениях стационаров.

2.5. Медицинские сестры процедурные и медицинские сестры приемных отделений стационаров:

- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП

3.1. Подготовительные операции:
Определить места хранения ЛС и МИ (шкаф для хранения ЛС и МИ):
- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху:

ШКАФ № 1
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УКЛАДКИ

ШКАФ № 2
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Пронумеровать полки шкафов (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.).
Подписать полки шкафа шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

Полка №1

Полка №2

И т. д.

- Определить места на полках шкафа №1:
• полки № 1 - № 3 – противошоковая укладка, укладка по профилактике парентеральных инфекций.
• полки № 4, № 5 – укладка для оказания для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме по приказу МЗ РФ от 30 октября 2020 г. N 1183н. Мешок Амбу и другие изделия медицинского назначения для оказания н/п.
- Определить места на полках шкафа №2:
• полка № 1 – стерильные ИМН;
• полки № 2 - № 4 – расходные медицинские изделия;
• термолабильных с интервалом хранения от +2 до +8 ° С – холодильник № __;
• иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) с интервалом хранения от +2 до + 8 °С – холодильник № ___.
Примечание: допускается хранение МИ и укладок на отдельных полках шкафа (в отдельной секции) совместно с ЛС при отсутствии отдельного шкафа.

4. Хранение лекарственных препаратов

4.1. Разместить укладки и МИ по местам хранения (шкаф медицинский) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковках ЛС и МИ и определенным местам в шкафах.
4.2. Лекарственные средства и медицинские изделия в укладках размещаются в потребительской упаковке.
4.3. На внутренней левой дверце шкафа на уровне глаз размещается список ЛС и МИ, находящихся в шкафу.
Шрифт №14:
Надпись «СПИСОК СОДЕРЖИМОГО шкаф №___»
Шрифт №12 Наименование граф в таблице;
Шрифт №12 в самой таблице.

СПИСОК СОДЕРЖИМОГО
шкаф № ___

Наименование ЛС, МИ	серия	Срок годности	Номер полки

4.4. Укладки неотложной помощи хранятся в опечатанном виде. При опечатывании ставится дата предполагаемого вскрытия и подпись старшей медицинской сестры филиала/отделения на опечатывающий стикер. Предполагаемая дата вскрытия укладок – 3 месяца до истечения срока годности ЛС и МИ. На внешней стороне укладки прикрепляется список ЛС и МИ:

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ **укладка**			
Наименование лекарственного препарата (МИ), дозировка.	**форма выпуска**	**серия**	**Срок годности**

Первый истекающий срок годности выделяется маркером. Упаковки ЛП в укладках должны быть промаркированы в соответствии с приложением № 2 настоящего приказа «Инструкция по маркировке упаковок лекарственных препаратов».

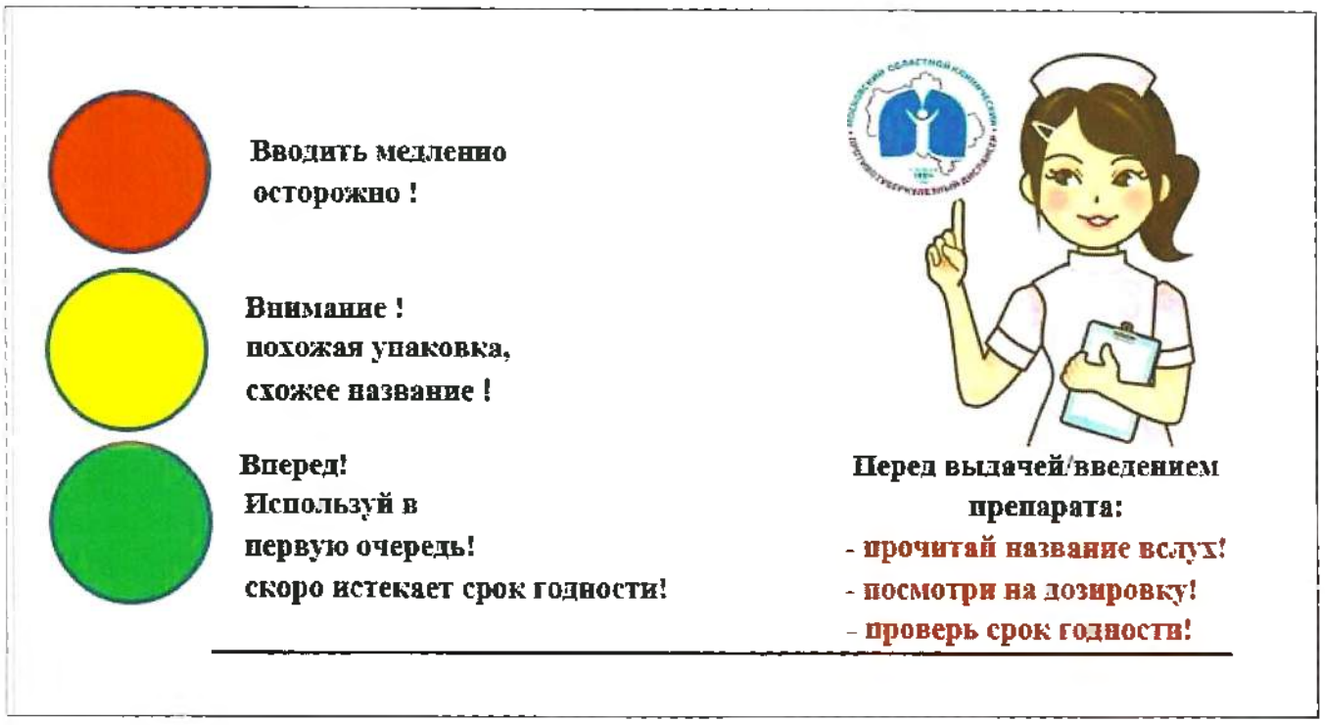
При использовании ЛС из укладок для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме по приказу МЗ РФ от 30 октября 2020 г. N 1183н, информация об использованных ЛС, их количестве заносится в журнал:

Дата/ время	ФИО пациента	Причина оказания неотложной помощи (диагноз)	Наименование ЛС, выданного/введенного пациенту	ФИО и подпись врача	ФИО и подпись медсестры

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью руководителя клиники/филиала и печатью. Журнал хранится в шкафу, рядом с укладкой. При остатке ЛС не более половины упаковки, они подлежат замене, а остаток препаратов может быть передан в лечебные отделения для использования.

4.5. На внутреннюю поверхность правой дверцы шкафа (ровно в середине, на уровне глаз) прикрепляется памятка о маркировке упаковок с лекарственными препаратами. Размер А5

(14,8x21 см.). Ниже указанной памятки, прикрепляется памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (приложение 21). Данные памятки должны быть заламинированы.



4.6. Шкафы с лекарственными препаратами должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным препаратам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность должна быть до 65%. Измерительные части гигрометров должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 - 1,7 м от пола.

5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.

5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельные тары (пластиковые корзины/контейнеры). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.

5.4. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), **каждой камеры холодильника**: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и в конце смены фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).

5.5. Если в холодильнике (+2 °С до +8 °С) температура ниже +2 °С или выше +8 °С, а в холодильнике (+8 до + 15 °С) ниже +8 °С или выше + 15 °С, попытаться отрегулировать холодильник, через 1 час проверить. Если температура не поднялась или опустилась до положенной, отключить холодильник. Переместить ЛС в резервный холодильник или в термоконтейнер с хладоэлементами. Поставить в известность старшую медицинскую сестру.
5.6. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 7 дней во время генеральных уборок, холодильников 1 раз в 7 дней, во время генеральных уборок, если это не противоречит рекомендациям производителя холодильного оборудования.
5.7. Контроль за сроками годности препаратов проводить:
- при получении ЛС и МИ у старшей медицинской сестры;
- перед введением препарата пациенту;
- во время генеральной уборки (1 раз в 7 дней).
5.8. При выявлении ЛС с остаточным сроком годности три месяца и менее, поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения.
5.9. При выявлении ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в соответствующую **«карантинную зону» у старшей медицинской сестры отделения.**
5.10. Располагать лекарственные средства и медицинские изделия внутри шкафа необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных препаратов в процедурных кабинетах амбулаторных отделений и в приемных отделениях.

6.1. Помещения (процедурные кабинеты) должны быть оснащены в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС при их хранении.
6.2. Помещения оснащаются шкафами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.
6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.
6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.
6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.
6.7. Помещения для хранения ЛС и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.
6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛС и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже 1 раза в 7 дней.
6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

Приложение 9
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«О хранении лекарственных средств и медицинских изделий у старших медицинских сестер филиалов и их структурных отделений, осуществляющих амбулаторный этап лечения пациентов»

(за исключением наркотических средств и психотропных веществ)

2024 год.

1. Область применения:

Где	Кабинеты, где осуществляется хранение запаса лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее – МИ)
Когда	Постоянно

2. Ответственность.

2.1. Руководитель организации:

- за организацию условий для выполнения требований СОП;
- обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛП.

2.2. Заведующая аптекой – провизор, главная медицинская сестра:

- за наличие в структурных подразделениях данной инструкции (СОП);
- своевременную актуализацию СОП;
- за проведение инструктажа по данному вопросу;
- за контроль соблюдения данной процедуры. Контроль за соблюдением правил осуществляется в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

2.3. Старшие медицинские сестры филиалов и их структурных подразделений:

- за наличие в филиалах и в их структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;
- за организацию условий хранения ЛС и МИ у старших медицинских сестер амбулаторных подразделений;
- за сохранность и правильность хранения лекарственных средств и медицинских изделий в кабинетах, где осуществляется хранение лекарственных средств;
- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей.

3. Основная часть СОП

3.1. Подготовительные операции:

Определить места хранения ЛС и МИ (шкафы для хранения ЛС и МИ или стеллажи):

- Приготовить (распечатать) этикетку большими буквами, шрифт «Times New Roman» размер 22), выделить жирным начертанием: и прикрепить на левой наружной двери шкафа сверху или на внешнюю поверхность стеллажей:

ШКАФ № 1
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ШКАФ № 2
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ШКАФ № 3
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СТЕЛЛАЖ № 1
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Пронумеровать полки шкафа и стеллажей (сверху вниз, полка №1 – верхняя и т. д.). Подписать полки шкафа/стеллажа шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием:

Полка №1

Полка №2

И т. д.

- Определить места на полках шкафов/стеллажей для хранения ЛС и МИ: промаркировать полки, согласно фармакологическому ряду препаратов и названию МИ.
• термолабильных с интервалом хранения от +2 до +8 °С – холодильник № __;
• термолабильных с интервалом хранения от +8 до + 15 °С – холодильник № ___;
• иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) с интервалом хранения от +2 до + 8 °С – холодильник № ___.

4. Хранение лекарственных препаратов

4.1. Разместить ЛС и МИ по местам хранения (шкаф медицинский/стеллаж) в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке ЛС и определенным местам в шкафах/стеллажах.

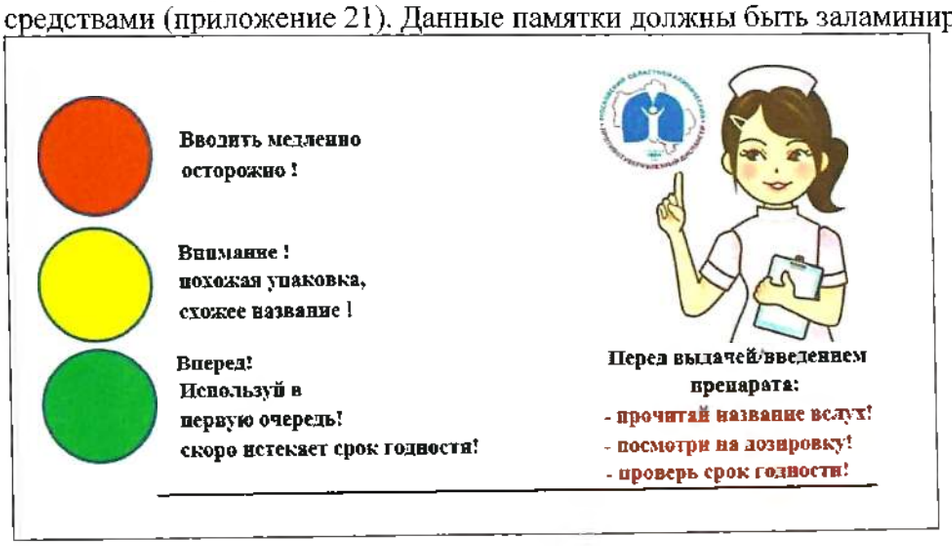
4.2. Лекарственные препараты и медицинские изделия размещаются в потребительской упаковке. Не допускается хранение ЛС и МИ в транспортных упаковках. Допускается размещение препаратов в потребительских упаковках в специальных пластиковых контейнерах (сетчатых корзинах). На контейнеры прикрепляются этикетки с наименованием фармакологического ряда размещенных в них препаратов (пример: противотуберкулезные препараты, антибиотики и т.п.). При отсутствии контейнеров, ЛС размещаются непосредственно на полках шкафа. В этом случае этикетки с наименованием фармакологического ряда препаратов прикрепляются непосредственно на внутреннюю поверхность стены шкафа или в другое место непосредственно на полку. Для этикеток использовать шрифт «Times New Roman" №16, выделить жирным начертанием. Стеллажные карты размещаются рядом с упаковками ЛС, не закрывая название, срок годности и серию ЛС. Стеллажная карта распечатывается из программы ЕМИС МО БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА. Стеллажная карта должна содержать следующую информацию: (наименование ЛС, форма выпуска, дозировка, серия, срок годности, производитель). Размер стеллажной карты 60 х 80 мм. ПРИМЕР:

Собственные средства	
Дексаметазон-Ферейн, р-р д/инф., 4 мг/мл,2 мл, №25 - ампулы (25) - картонная пачка. От: АО БРЫНЦАЛОВ-А(РОССИЯ) [ДЕКСАМЕТАЗОН]	
Дата поставки	22.04.2024
Партия	РН-М0011143
Поставщик	ООО "Мартфарм"
Производитель	АО БРЫНЦАЛОВ-А
Серия	420322
Срок годности	01.03.2025

4.3. На внутренней левой дверце шкафа размещается список препаратов, находящихся в шкафу.
Шрифт №14: **Надпись «СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ шкаф №___»**
Шрифт №12 Наименование граф в таблице;
Шрифт №12 в самой таблице: (список постоянно актуализируется)

Номер полки	**Наименование лекарственного средства, дозировка**	**форма выпуска**	**Срок годности**	**Высшая разовая доза (для сильнодействующих ЛС)**	**Высшая суточная доза (для сильнодействующих ЛС)**
№ 1					
№ 1					
№ 2					
№ 2					
№ 2					
№ 3					
№ 3					

4.4. На внутреннюю поверхность правой дверцы шкафа (ровно в середине) прикрепляется памятка о маркировке упаковок с лекарственными препаратами. Размер А5 (14,8х21 см.) Ниже указанной памятки, прикрепляется памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами (приложение 21). Данные памятки должны быть заламинированы.



4.5. Шкафы с лекарственными препаратами должны запираться. Посторонним лицам доступ к лекарственным препаратам запрещен.

5.**Обеспечение необходимых условий хранения.**

5.1. Ежедневно, в начале рабочего дня и в выходные и праздничные дни контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (приложение 28). Температура в помещениях хранения должна быть до + 25 °С, влажность - до 65%.

5.2. Если температура выше +25 °С – включить кондиционер (или отключить отопление), открыть окно на проветривание.

5.3. При невозможности обеспечить в помещении требуемую температуру (до 25° С) (отсутствие/поломка кондиционера), переместить препараты в холодильники или в помещения, оборудованные системами кондиционирования воздуха. Препараты поместить в отдельную тару (пластиковую корзину/контейнер). Тару промаркировать: наименование помещения откуда перемещены ЛС, перечень ЛС, дата перемещения, должность, ФИО и подпись ответственного лица.

5.4. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), **каждой камеры холодильника**: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и в конце рабочей смены. Показания фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).

5.5. Если в холодильнике (+2 °С до +8 °С) температура ниже +2 °С или выше +8 °С, а в холодильнике (+8 до + 15 °С) ниже +8 °С или выше + 15 °С, попытаться отрегулировать холодильник, через 1 час проверить. Если температура не поднялась или опустилась до положенной, отключить холодильник. Переместить ЛС в резервный холодильник или в термоконтейнер с хладоэлементами. Поставить в известность заведующего отделением и специалиста по медицинской техники отдела АХО. Записать в журнал нежелательных событий. Сформировать заявку на ремонт оборудования.

5.6. Санитарную обработку шкафов производить 1 раз в 7 дней во время генеральных уборок, холодильников 1 раз в 7 дней, во время генеральных уборок, если это не противоречит рекомендациям производителя холодильного оборудования.

5.7. Контроль за сроками годности ЛС и МИ проводить:

- при получении ЛС и МИ из аптеки;
- при выдаче препаратов на посты, в процедурные и т.п.;
- во время генеральной уборки (1 раз в 7 дней).

5.8. При выявлении ЛС с остаточным сроком годности меньше трех месяцев, поставить в известность заведующего отделением и заведующую аптекой ГБУЗ МО «МОКПТ». Разместить информацию о количестве препаратов в телеграмм-чат.

5.9. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида, (йодоформ, перекись водорода, гидрокарбонат натрия); следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги).

5.10. Информацию о наличии ЛС и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, старшие медицинские сестры получают через сообщения в телеграмм-чатах «Мониторинг лекарственных средств», «Старшие медицинские сестры» или из писем на электронные почты отделений. Старшие медицинские сестры обязаны проводить мониторинг данных чатов и почты не реже 3 раз в день. При выявлении

ЛС и МИ (в кабинете основного запаса, процедурных, кабинетах выдачи ЛС), в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛС, обращение которых приостановлено, они должны быть перемещены в этот же день в соответствующую «карантинную зону».

- **Зона карантинного хранения:** приостановка обращения; несоответствие товарно-сопроводительной документации; сомнение в подлинности или качестве. В данной зоне необходимо поддержание условий хранения ЛС и МИ. ЛС без особых условий хранения – в обычных помещения или зонах хранения – выделяется отдельный шкаф или полка; термолабильные в холодильниках – выделяется отдельные холодильник или полка, иммунобиологические в холодильниках для ИЛП – выделяется отдельные холодильник или полка; подлежащие ПКУ в специальных шкафах или сейфах – выделяется отдельный шкаф/сейф или полка. При решении Росздравнадзора о возвращении в оборот данных ЛС и МИ, они выдаются в отделения, при решении о прекращении использования перемещаются в зону изъятых из обращения ЛС и МИ с дальнейшей их утилизацией или возврату Поставщику.

Данная зона должна иметь маркировку (шрифт Times New Roman, Размер шрифта: оглавление 24, выделено жирным текстом, текст – 16). Размер маркировки 15х7 см.

Зона карантинного хранения
- приостановка обращения ЛС;
- несоответствие товарно-сопроводительной документации;
- сомнения в подлинности и качестве.

- **Зона изъятых из обращения ЛС и МИ:** - фальсифицированные, некачественные, контрафактные, с истекшим сроком годности ЛС и МИ. Данная зона не требует специальных условий хранения. Для этой зоны выделяется отдельный контейнер/шкаф/полка/стеллаж. ЛС, ДС из этой зоны передаются для их утилизации, как отходы класса Г по договору со специализированной организацией, а МИ подлежат утилизации, как отходы класса Б.

Данная зона должна иметь маркировку (шрифт Times New Roman, Размер шрифта: оглавление 24, выделено жирным текстом, текст – 16). Размер маркировки 15х7 см.

Карантинная зона для ЛС, изъятых из обращения
- фальсифицированные;
- недоброкачественные;
- контрафактные;
- с истекшим сроком годности.

5.13. Располагать лекарственные препараты и медицинские изделия внутри шкафа и на стеллажах необходимо таким образом, чтобы препараты с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса. Лекарственные препараты хранятся в потребительской упаковке и размещаются этикеткой (маркировкой) наружу.

6. Требования к помещениям хранения лекарственных средств и медицинских изделий у старших медицинских сестер стационарных отделений:

6.1. Помещение должно быть оснащено в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛС и МИ при их хранении.

6.2. Помещения оснащаются шкафами, стеллажами, холодильниками, таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи или светоотражающей пленкой.

6.3. Помещения должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛС.
6.4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
6.5. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.
6.6. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.
6.7. Помещения для хранения ЛП и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте, на высоте 1,5–1,7 м от пола.
6.8. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛП и МИ проводятся в соответствии с соответствующей инструкцией, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» не реже 1 раза в 7 дней.
6.9. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.
6.10. В помещении должна быть выделена зона приемки ЛС из аптеки (стол, кушетка). Зона приемки должна быть предназначена для сортировки поступивших ЛС и МИ из аптеки ГБУЗ МО «МОКПТД»

Приложение 10
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

2024 год

«Порядок хранения термолабильных лекарственных средств и иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) в аптеке и структурных подразделениях ГБУЗ МО «МОКПТД»

Цель: стандартизация процедуры хранения термолабильных и иммунобиологических лекарственных препаратов.

Область применения

Где: помещения хранения.

Когда: при хранении лекарственных средств.

Ответственность: сотрудник, ответственный за хранение лекарственных препаратов.

Общая часть СОП

1.Требования к оборудованию для "холодовой цепи"

1.1. В системе "холодовой цепи" используются следующие виды оборудования:
оборудование для транспортирования;
оборудование для хранения;
оборудование для контроля температурного режима хранения и транспортирования.

1.2. Покрытие внутренних и внешних поверхностей оборудования должно быть устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств.

1.3. Для бесперебойной работы холодильного оборудования и электрических приборов для контроля температурного режима необходимо обеспечить стабильность напряжения в электросетях, осуществляющих энергоснабжение данного оборудования, а также возможность электроснабжения по резервным схемам или автоматическое подключение системы автономного электропитания (электрогенераторов или аккумуляторов).

1.4. Запрещается использовать оборудование для совместного с ИЛП хранения и транспортирования продуктов питания, других лекарственных средств, а также сырья, материалов, оборудования и предметов, которые могут повлиять на качество препаратов и/или повредить их упаковку.

1.5. Необходимо строгое соблюдение сроков эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определенных его производителем.

1.6. Оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения ИЛП, должно обеспечивать:

- требуемый температурный режим или заданный интервал температур в течение всего времени транспортирования и хранения при любой допустимой степени загрузки. Не допускается превышение объема загрузки холодильного оборудования более чем на 2/3;
- замораживание и хранение в замороженном состоянии достаточного количества хладоэлементов, используемых в комплекте с термоконтейнерами или в качестве аварийных источников холода в стационарном холодильном оборудовании.

2.Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП

2.1. В системе "холодовой цепи" для транспортирования ИЛП используется следующее оборудование:

- сверхмалые термоконтейнеры для ИЛП (емкостью до 10 дм^3 включительно);
- малые термоконтейнеры емкостью более 10 дм^3 до 30 дм^3 включительно (в том числе медицинские сумки-холодильники);
- термоконтейнеры (средние более 30 дм^3 до 50 дм^3 включительно, большие более 50 дм^3 до 100 дм^{3}включительно и сверхбольшие более 100 дм^3);

- хладоэлементы;
2.2. Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом ИЛП упаковываются в специальные термоконтейнеры, изготовленные из теплоизоляционного материала, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение определенного времени для защиты ИЛП от воздействия высоких или низких температур окружающей среды.
2.3. Термоконтейнеры емкостью до 50 дм^3 включительно должны обеспечивать температурный режим хранения и транспортирования от +2 °С до +8 °С:
- не менее 24 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды +34 °С;
- не менее 6 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды -20 °С.
2.4. Термоконтейнеры емкостью свыше 50 дм^3 должны обеспечивать температурный режим хранения и транспортирования от +2 °С до +8 °С:
- не менее 48 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды +43 °С;
- не менее 10 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды -30 °С.
2.5. Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы паспортом, термокартой, инструкцией по применению, должны иметь покрытие, легко подвергающееся санитарной обработке.
2.6. Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы двойным комплектом хладоэлементов, один из которых используется для загрузки термоконтейнера, другой - замораживается в морозильнике.
2.7. Термоконтейнеры емкостью до 30 дм^3 включительно (медицинские сумки-холодильники) должны обеспечиваться средствами для ручного транспортирования и иметь прочную наружную поверхность для защиты от случайного механического и другого повреждающего воздействия окружающей среды.
2.8. Термоконтейнеры емкостью более 30 дм^3 до 50 дм^3 включительно (средние термоконтейнеры) должны обеспечиваться средствами, облегчающими их ручное транспортирование, защищены от случайного механического и другого повреждающего воздействия окружающей среды.
2.9. Загруженные большие (свыше 0 дм^3 до 100 дм^3) и сверхбольшие (свыше 100 дм^3) термоконтейнеры перемещаются с помощью механических транспортных средств.
2.10. Запрещается использование термоконтейнеров с механическими повреждениями стенок и/или крышки как внутри, так и снаружи.
2.11. Санитарная обработка термоконтейнеров многократного применения проводится перед загрузкой и после использования, а также по мере необходимости, с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с паспортом и инструкцией по применению термоконтейнеров.
2.12. Загрузка ИЛП производится в термоконтейнер, предварительно охлажденный до температуры от + 2 °С до + 8 °С (если в инструкции к термоконтейнеру не предусмотрен другой режим подготовки). Сверхмалые и малые термоконтейнеры охлаждаются в холодильнике (холодильной камере), остальные - либо в холодильных комнатах (камерах), либо с помощью резервного запаса хладоэлементов.
2.13. Для создания необходимой температуры внутри пассивного термоконтейнера используются хладоэлементы. В хладоэлементах могут использоваться жидкие и гелеобразные наполнители.
Хладоэлементы, содержащие в качестве наполнителя воду, должны иметь маркировку "вода".
Хладоэлементы, содержащие другие наполнители, должны иметь маркировку рабочих температур, указанных в инструкции на хладоэлемент. Запрещается использование сухого льда в пассивных термоконтейнерах при транспортировании и хранении ИЛП.
2.14. Хладоэлементы используются в соответствии с инструкцией их производителя и требованиями, изложенными в прилагаемых паспорте и/или инструкции к термоконтейнеру или хладоэлементу.
Перед загрузкой в термоконтейнеры замороженные водяные хладоэлементы (если другое не предусмотрено инструкцией) выдерживаются при комнатной температуре для оттаивания инея на их поверхности и при необходимости - кондиционирования (частичного размораживания). Перед использованием их вытирают насухо.
Между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов необходимо размещать изолирующий материал (например, картон или бумагу).

2.15. При транспортировании в одном пассивном термоконтейнере ИЛП различных видов, в том числе не допускающих замораживание, и растворителей к вакцинам, для предотвращения замораживания ИЛП используются кондиционированные (частично размороженные) хладоэлементы с наполнителем из воды либо другие с рабочими температурами в интервале от +2 °С до +8 °С, если иное не предусмотрено инструкцией к термоконтейнеру.

2.16. При транспортировании ИЛП в термоконтейнере (активном или пассивном) используется оборудование для контроля температурного режима: термоиндикаторы, которые позволяют установить, были ли нарушения температурного режима в течение всего цикла транспортирования. Допускается использование термометров со встроенной электронной памятью, обладающих возможностью фиксации нарушений температурного режима в цикле контроля.

Оборудование для контроля температурного режима размещается в каждом термоконтейнере в месте, рекомендованном производителем согласно термокарте, между упаковками с ИЛП. Контроль показаний приборов осуществляется после окончания цикла транспортирования во время выгрузки препаратов.

3.Требования к оборудованию для хранения ИЛП

3.1 В системе "холодовой цепи" для хранения ИЛП используются холодильники, характеризующиеся высокой степенью надежности (далее - холодильники для "холодовой цепи"), в том числе с технической возможностью длительного (не менее 24 часов) удержания надлежащего температурного режима внутри холодильной камеры при отключении электроэнергии, стабильностью температурного режима внутри камеры, не допускающего выход за пределы интервала температур в пределах от +2 °С до +8 °С и исключающего возникновение локальных зон отрицательных температур, связанных с работой хладогенератора. Холодильники должны быть оборудованы перенавешиваемыми дверцами без полок, встроенным термометром с дисплеем для визуального контроля температуры и температурной звуковой сигнализацией.

3.2 Полки холодильника, выделенные для хранения отдельных ИЛП, маркируются соответствующим образом. Не допускается размещение ИЛП на полках дверной панели холодильника.

3.3. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха не допускается загрузка объема камеры холодильника более чем на 2/3.

3.4. В каждой холодильной камере холодильника предусматривается место для размещения хладоэлементов (не менее 1/6 общего объема холодильной камеры), которые служат дополнительными источниками холода при отключении электроснабжения холодильника.

3.5. Холодильник помимо встроенного термометра оснащается двумя автономными термометрами и двумя термоиндикаторами (терморегистраторами).

Автономные термометры и термоиндикаторы (терморегистраторы) размещаются рядом друг с другом непосредственно на коробках с ИЛП или непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), каждой камеры холодильника: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода).

3.6. Генеральная уборка холодильника с отключением от источника электроснабжения, мытьем и обработкой дезинфицирующими средствами внутренних и наружных поверхностей проводится не реже одного раза в месяц, текущая уборка - по мере необходимости.

3.7. Для замораживания хладоэлементов в условиях процедурного кабинета можно использовать морозильное отделение двухкамерного бытового холодильника. В морозильном отделении холодильника могут также храниться форма для замораживания льда и пузырь со льдом для оказания экстренной медицинской помощи. Запрещается хранить в морозильном отделении холодильника продукты и посторонние предметы.

Основная часть СОП

1. Подготовительные мероприятия

1.1. Определить места хранения термолабильных лекарственных препаратов:

– хранить термолабильные лекарственные препараты с интервалом температур хранения от +2 до +8 градусов С в холодильнике № ___;

– хранить термолабильные лекарственные препараты с интервалом температур хранения от +8 до +15 градусов С в холодильнике № ____;

– хранить иммунобиологические лекарственные препараты в холодильнике № __ с интервалом температур хранения от +2 до +8 градусов С;

1.2. Разместить автономные термометры в холодильники, согласно термокарте оборудования. Если термокарта не указана в паспорте оборудования, то на нижней и средней полках холодильников (в зависимости расположения источника холода в конкретном оборудовании, в самых «теплой» и «холодной» точках). Контролировать температуру (показания температуры снимаются с автономных термометров) в холодильниках в 8.00 (в начале смены) и в конце рабочей смены. Показания фиксировать в журнале «Температурный режим холодильного оборудования» (приложение 27).

1.3. Разместить автономные термометры и термоиндикаторы в холодильники, согласно термокарте оборудования. Количество и месторасположения (самые «теплые» и «холодные» точки) автономных термометров и термоиндикаторов указано в термокарте для каждого конкретного холодильного оборудования. Автономные термометры и термоиндикаторы размещаются непосредственно на полках в двух контрольных точках (согласно термокарте оборудования), каждой камеры холодильника: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). Автономные термометры и термоиндикаторы размещаются непосредственно на коробках с ИЛП рядом друг с другом.

2. Хранение лекарственных средств

2.1. Разместить лекарственные препараты в холодильниках в соответствии с условиями хранения, указанными на вторичной упаковке и в инструкции по медицинскому применению.

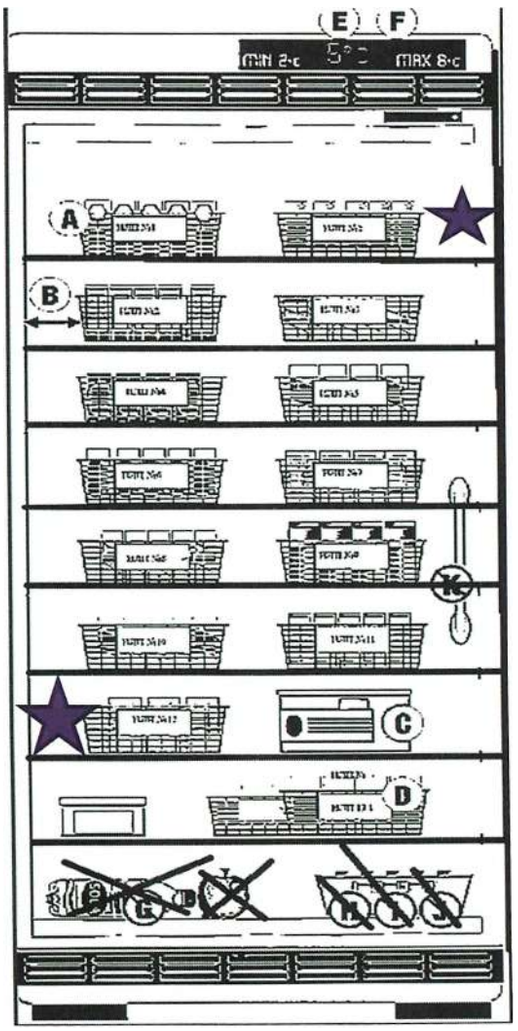
A. Поместите ИЛП в воздухопроницаемые пластиковые корзины. Четко маркируйте корзины с помощью стеллажной карты

B. Держите корзины от 5 до 8 см от стен и других корзин. Храните вакцину в оригинальной упаковке до её

K. Убедитесь, что дверь холодильника для хранения ИЛП не пропускает световые лучи. Не открывайте дверь холодильника без лишней необходимости

Идентифицируйте и подпишите все полки внутри

G. Не храните еду и напитки в холодильнике для вакцин. H. I. J. Не помещайте ИЛП в воздухонепроницаемые контейнеры. Не кладите вакцины на «пол» холодильника



F. Звуковой сигнал должен информировать о нарушении

E. Температура должна находиться в диапазоне от 2°С до 8°С (стремитесь к 5°С) Проверяйте и регистрируйте температуру дважды в день: утром и вечером. ★ Размещайте термометры в «теплой» и «холодной» зонах. (по термокарте оборудования) Термометры должны быть поверены. Рядом с ними располагают термоиндикаторы

C. Разместите в холодильнике: 1. Карантинную зону; для хранения препаратов, реализация которых приостановлена (письмо Росздравнадзора),

D. Храните ИЛП с более короткими сроками годности впереди

3. Обеспечение необходимых условий хранения

3.1. Ежедневно два раза в день, контролировать параметры температуры (термометры) в холодильниках – в 08:00 и в конце рабочего дня. Контроль показаний каждого термоиндикатора в оборудовании для хранения ИЛП осуществлять два раза в сутки (08:00 и в конце рабочего дня). Показания каждого термоиндикатора с указанием его персонифицированного номера регистрировать в специальном журнале мониторинга температуры, который заполняется отдельно на каждую единицу холодильного оборудования (Приложение 27 к настоящему приказу). В том же журнале регистрируются факты планового или аварийного отключения холодильного оборудования от энергоснабжения, поломок и факты нарушения температурного режима с указанием даты и времени отключения.

3.2. Фиксировать параметры температуры в журнале (Приложение 27) регистрации температурного режима в холодильнике. В холодильнике № ___ температура должна быть +2 – +8 градусов С, холодильниках № ___ +8 - +15 градусов С, в холодильнике № __ +2 – +8 градусов С.

3.3. Если температурный режим в холодильниках не соответствует параметрам, указанным в пункте 3.2, его необходимо отрегулировать и через час проверить.

3.4. Если температура не выходит на установленный интервал, переместить лекарственные препараты в термоконтейнеры с хладоэлементами. Хладоэлементы взять из морозильной камеры холодильника №__. Поставить в известность заведующего отделением и специалиста по медицинской технике АХО. Принять все меры для возобновления нормативной работы холодильного оборудования. Записать в журнал нежелательных событий. Сформировать заявку на ремонт оборудования. Если работа холодильного оборудования не может быть восстановлена в ближайшее время, переместить ЛС в резервный холодильник.

3.5. Фиксировать в журнале регистрации факты аварийного или планового отключения холодильника.

Приложение 11
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

2024 год

«Правила использования хладоэлементов и их хранения»

Цель: поддержание заданного температурного режима внутри термоконтейнеров, необходимого для транспортирования и временного хранения термолабильных препаратов и биологического материала в индивидуальной упаковке (далее по тексту – препаратов).

Где: ГБУЗ МО «МОКПТД»

Когда: при хранении и транспортировке ИЛП, термолабильных лекарственных средств, в том числе материалов крови.

Ответственность: процедурная медицинская сестра, старшая медицинская сестра отделения.

Для создания необходимой температуры внутри пассивного термоконтейнера используются хладоэлементы. В хладоэлементах могут использоваться жидкие и гелеобразные наполнители.

Хладоэлементы, содержащие в качестве наполнителя воду, должны иметь маркировку "вода".

Хладоэлементы, содержащие другие наполнители, должны иметь маркировку рабочих температур, указанных в инструкции к хладоэлементу.

Действия с хладоэлементами необходимо производить в точном соответствии с инструкцией производителя и требованиями, записанными в паспорте или инструкции к термоконтейнеру или хладоэлементу.

1. Алгоритм подготовки хладоэлементов к применению:

1.1. Хладоэлементы проверьте на отсутствие механических повреждений в корпусе. Убедитесь в герметичности хладоэлемента.

1.2. Нужное количество хладоэлементов уложить в морозильную камеру. Режим заморозки: температура - 20°С ±2°С, время 22 ± 2 часа.

Примечание: Хладоэлементы замораживать лежа. При заморозке необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в вертикальном и в горизонтальном направлениях.

1.3. Замороженные до -20°С хладоэлементы разместить на плоской поверхности в помещении с температурой +22(±2)°С и выдержать ориентировочно в течение 1 часа. Готовность хладоэлементов можно проверить по:

- отсутствию инея на корпусе;
- появлению в хладоэлементах жидких фракций (всплески при встряхивании).

1.4. Выдержанные в течение необходимого времени хладоэлементы протереть насухо и уложить в пустые термоконтейнеры. Укладку производить максимально возможно по стенкам термоконтейнера.

1.5. Термоконтейнеры с уложенными по стенкам хладоэлементами закрыть крышкой и оставить в помещении на 1-1,5 часа для стабилизации температуры внутри контейнера.

1.6. Для контроля температурного режима при хранении или транспортировании препарата в термоконтейнер поместите термоиндикатор или автономный термометр со встроенной электронной памятью.

2. Хранение и транспортирование:

2.1. Хладоэлементы храните в закрытых прохладных, защищенных от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м. от отопительных устройств.

2.2. Хладоэлементы оберегайте от падения, ударов, воздействия колющих и режущих предметов.

Запрещено вскрывать хладоэлементы!

2.3. Транспортирование хладоэлементов допускается всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С и относительной влажности не выше 80%.

3. Дезинфекция хладоэлементов:

3.1. Проводите их периодическую дезинфекцию не реже одного раза в месяц, путем протирания дезинфицирующим средством методом двукратного протирания.

3.2.После использования хладоэлементы протрите сухой салфеткой для удаления конденсата и просушите.

4. Утилизация хладоэлементов:

4.1. Запрещается использовать поврежденные хладоэлементы для временного хранения и транспортировки препаратов.

4.2. Хладоэлементы поврежденные, с истекшим сроком эксплуатации, а также непригодные для использования по прямому предназначению по иным причинам, подлежат утилизации как медицинские отходы класса А (из аптеки), отходы класса Б (из отделений).

Приложение 12

к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»

от «25» мая 2024г. № 116/24

Алгоритм закладки термоконтейнера BlueLin Bag 30L (для ИБП и термолабильных препаратов, крови)

Осмотреть контейнер (не должно быть повреждений)

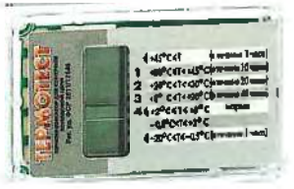
Охладить контейнер до необходимой температуры +2-+8 (поместить в холодильник или с помощью замороженных хладоэлементов

Охладить хладоэлементы Accu600мл. (при т +2,+4 не менее 12-24 ч.) Для быстрого охлаждения в морозильной камере не менее 0,5 часа

Хладоэлементы (другой марки) использовать по инструкции к ним и по инструкции к термоконтейнеру

Замороженные водяные хладоэлементы рекомендуется применять для охлаждения термоконтейнеров и дополнительного источника холода в холодильном оборудовании при аварийных ситуациях

Хладоэлементы разместить в контейнере по бокам, между стенкой контейнера и пластиковой емкостью для препаратов



В пластиковую емкость разместить лекарственные препараты или донорскую кровь (препараты крови)

Разместить термоиндикатор и автономный термометр между упаковками ЛС (крови), в середине контейнера

Закрыть контейнер. Произвести транспортировку лекарственных средств (крови)

После транспортировки снять показания термоиндикатора и термометра, занести их в журнал

Обработать контейнер раствором ДС, рекомендуемое производителем (3% перекись водорода или ДС на основе пероксида)

Приложение 13

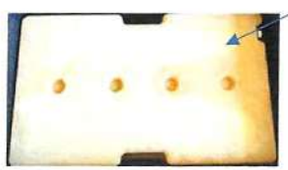
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»

от «25» мая 2024г. № 116/24

Алгоритм закладки термоконтейнера TransPorter BlueLin Bag 30L (для плазмы)

Осмотреть контейнер (не должно быть повреждений)

Охладить контейнер до необходимой температуры (поместить в холодильник или с помощью замороженных хладоэлементов

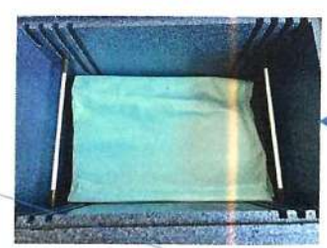


Хладоэлемент -30 гр. С Freeze Element 3L хранится при Т ниже -35 гр. С

Полностью открыть контейнер

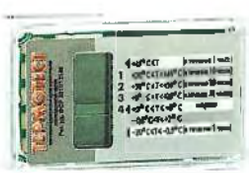
Разместить замороженную плазму

Вставить опорные шпильки в пазы до нужной высоты. Положить изолирующую прокладку на упаковки с плазмой



Положить хладоэлемент на опорные шпильки

Разместить термоиндикатор и автономный термометр между упаковками плазмы в середине контейнера



Закрыть контейнер, при необходимости опечатать и произвести транспортировку

После транспортировки снять показания термоиндикатора и термометра, занести их в журнал

Обработать контейнер раствором ДС, рекомендуемое производителем (ДС на основе пероксида)

Приложение 14
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

Алгоритм действий персонала в случае отключения электроэнергии

В филиале имеется дизельный генератор

При отключении электричества в течении 1 минуты произойдет запуск генератора

Электропитание восстановлено

Генератор запущен

Электропитание отсутствует, генератор не запустился

Сообщить ответственному лицу.
ФИО_____

№тел_____

Ответственное лицо сообщает в электросети о поломке:

(№ тел_____).

При наличии <u>стационарного отделения</u> в филиале: вызов автомобиля МЧС с мобильным дизельным генератором

Дизельный генератор отсутствует

Сообщить ответственному лицу.
ФИО_____
№тел_____

При невозможности восстановления электропитания в течении 12 часов (при наличии фармацевтических холодильников), подготовить термоконтейнеры для транспортировки термолабильных и ИБП в_____

Приложение 15
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)
«Порядок хранения дезинфицирующих препаратов»
2024 год

Цель: стандартизация процедуры хранения дезинфицирующих средств

Область применения

Где: помещения хранения.

Когда: при хранении дезинфицирующих средств (далее – ДС).

Ответственность: старшая медицинская сестра, сотрудник, ответственный за хранение лекарственных препаратов.

Хранение запаса дезинфицирующих средств:

- запас моющих и дезинфицирующих средств хранят в специальных помещениях, оборудованных вентиляцией (принудительной или естественной), недоступных для посторонних лиц;
- размещаются дезинфицирующие средства на стеллажах, в шкафах. Стеллажи и шкафы, а также полки маркируются по видам дезинфицирующего средства (ДС на основе хлора, кислорода, третичных аминов, кожные антисептики, жидкое мыло и т.п.) или по названию ДС;
- хлор содержащие ДС хранятся в отдельном шкафу или на отдельной полке стеллажа (нижней);
- ДС хранятся в оригинальной упаковке производителя отдельно от лекарственных препаратов, расходных медицинских материалов, ИМН и пищевых продуктов, (в т.ч. запаса молока и питьевой воды);.
- дезинфицирующие средства следует хранить вдали от помещений хранения пластмассовых, резиновых и металлических изделий и помещений получения дистиллированной воды;
- запрещается хранение ДС в транспортных упаковках в отделениях, кроме отдельных помещений, предназначенных для хранения запаса ДС, превышающим 1 месяц (склады хранения ДС у старших медицинских сестер филиалов).

Приложение 16
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)
2024 год

«Выдача лекарственных средств пациентам в стационарных отделениях»

Цель: Лечебная
Показания: Назначение врача
Место введения: per os.
Оснащение: Лист назначений, ручка, таблетированные лекарственные препараты, манипуляционный столик, кожный антисептик, кувшин с питьевой водой,
Возможные проблемы пациента: Отказ от манипуляции; психологический дискомфорт, аллергической реакцией.
Область применения:

Где	Стационарные отделения ГБУЗ МО «МОКПТД».
Когда	При выдаче лекарственных средств пациентам для энтерального применения по листам назначений.

В стационарных отделениях ГБУЗ МО «МОКПТД можно использовать следующие способы выдачи лекарственных средств:

Способ №1 по палатам пациентов:

Этапы	Обоснование
I. Подготовка к процедуре	
1. Обработать руки антисептиком. Надеть нестерильные перчатки, СИЗ. Разместить на манипуляционном столике на верхней полке: - кожный антисептик, -кувшин с питьевой водой - листы врачебных назначений, ручка. В ящиках: - необходимые лекарственные препараты. На нижней полке манипуляционного столика: - емкость (лоток) для медицинских отходов класс «Б».	Обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала.
2. Подкатить манипуляционной столик к палате. Выдачу лекарственных средств осуществлять поочередно каждому пациенту по листам назначений. Предложить пациентам вымыть руки.	Эргономика действий медицинской сестры, удобство для пациентов.
3. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту (ФИО, должность сотрудника). Попросить пациента преставиться, назвать полностью ФИО и дату рождения; Выяснить у пациента были ли нежелательные реакции на прием назначенных лекарственных препаратов. Сверить данные пациента с листом назначения.	Установление контакта с пациентом.

4. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры.	Психологическая подготовка к манипуляции.
5. Получить его устное согласие.	Соблюдение прав пациента.
II. Выполнение процедуры	
1. Проверить срок годности лекарственного препарата.	Обеспечение лекарственной безопасности
2. Налить питьевую воду в индивидуальную кружку (чашку, стакан) пациента для запивания лекарственного средства. Выдать препарат из блистера, не касаясь ЛС руками, в ладонь пациента. Если ЛС находится во флаконе использовать пинцет или специальную ложку. При выдачи ЛС в виде суспензий: при помощи индивидуальной мерной ложки или мензурки отмерить нужное количество ЛС и выдать пациенту. После выдачи ЛС всем пациентам, мензурки и ложки подвергаются дезинфекции, мытью и хранятся на отдельной полке шкафа в сухом виде.	Обеспечение инфекционной безопасности.
3. Проконтролировать прием лекарственного средства пациентом.	Контроль приема ЛС.
4. Зафиксировать выполнение процедуры и реакции пациента на нее (при наличии) в листе назначений (+/v) и поставить подпись.	Обеспечение преемственности сестринского ухода.
III. Окончание процедуры	
1. Сообщить пациенту время следующего приема ЛП	
2. После раздачи ЛС всем пациента, переместить манипуляционный столик на пост медицинской сестры, ЛС разместить в шкафы для хранения согласно маркировки шкафов и полок.	Обеспечение лекарственной безопасности
3.Провести дезинфекцию манипуляционного столика (экспресс-дезинфекция или способом протирания салфетками с раствором ДС)	Обеспечение инфекционной безопасности и травматизма.
4. Снять перчатки, сбросить в емкость для сбора медицинских отходов класс «Б».	
5. Обработать руки кожным антисептиком, по окончанию внести запись в журнал ПКУ (если такие ЛС выдавались).	

<u>Способ №2 На посту медицинской сестры:</u>

Этапы	Обоснование
I. Подготовка к процедуре	
1. Обработать руки антисептиком. Надеть нестерильные перчатки, СИЗ. Разместить на манипуляционном столике на верхней полке: - кожный антисептик, -кувшин с питьевой водой - листы врачебных назначений, ручка. В ящиках: - необходимые лекарственные препараты. На нижней полке манипуляционного столика: - емкость (лоток) для медицинских отходов класс «Б».	Обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала. Эргономика действий медицинской сестры
2. Предложить пациентам вымыть руки, пригласить их подойти к посту медицинской сестры поочередно, взяв с собой индивидуальные кружки (чашки, стаканы)	Удобство для пациентов.
3. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту (ФИО, должность сотрудника). Попросить пациента преставиться, назвать полностью ФИО и дату рождения; Выяснить у пациента были ли	Установление контакта с пациентом.

нежелательные реакции на прием назначенных лекарственных препаратов. Сверить данные пациента с листом назначения.	
4. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры.	Психологическая подготовка к манипуляции.
5. Получить его устное согласие.	Соблюдение прав пациента.
II. Выполнение процедуры	
1. Проверить срок годности лекарственного препарата.	Обеспечение лекарственной безопасности
2. Налить питьевую воду в личную кружку (чашку, стакан) пациента для запивания лекарственного средства. Выдать препарат из блистера, не касаясь ЛС руками, в ладонь пациента. Если ЛС находится во флаконе использовать пинцет или специальную ложку. При выдачи ЛС в виде суспензий: при помощи индивидуальной мерной ложки или мензурки отмерить нужное количество ЛС и выдать пациенту. После выдачи ЛС всем пациентам, мензурки и ложки подвергаются дезинфекции, мытью и хранятся на отдельной полке шкафа в сухом виде.	Обеспечение инфекционной безопасности.
3. Проконтролировать прием лекарственного средства пациентом.	Контроль приема ЛС.
4. Зафиксировать выполнение процедуры и реакции пациента на нее (при наличии) в листе назначений (+/v) и поставить подпись.	Обеспечение преемственности сестринского ухода.
III. Окончание процедуры	
1. Сообщить пациенту время следующего приема ЛП	
2. После раздачи ЛС всем пациента, переместить манипуляционный столик на пост медицинской сестры, ЛС разместить в шкафы для хранения согласно маркировки шкафов и полок.	Обеспечение лекарственной безопасности
3.Провести дезинфекцию манипуляционного столика (экспресс-дезинфекция или способом протирания салфетками с раствором ДС)	Обеспечение инфекционной безопасности и травматизма.
4. Снять перчатки, сбросить в емкость для сбора медицинских отходов класс «Б».	Обеспечение инфекционной безопасности
5. Обработать руки кожным антисептиком, по окончанию внести запись в журнал ПКУ/ПТП (если такие ЛС выдавались).	Обеспечение инфекционной безопасности и учета ЛС.

Приложение 17
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«Правила обращения с личными лекарственными средствами пациентов в стационарных отделениях»

2024 год.

Цель: стандартизация процедуры приема личных лекарственных средств пациентов.

Область применения

Где: стационарное отделение.

Ответственность: медицинская сестра палатная, старшая медсестра стационарного отделения.

Нормативная документация:

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Основная часть СОП

1. При поступлении пациента в стационарное отделение, после сбора анамнеза, пациент осматривается врачом, уточняются сопутствующие заболевания.

2. При наличии сопутствующих заболеваний, уточняются какие лекарственные средства пациент принимает ежедневно. Если данных лекарственных средств нет в стационарном отделении, врач после беседы с пациентом предлагает пациенту передать все имеющиеся у него медикаменты на пост м/с для контролируемого лечения. Дежурной медицинской сестрой заполняется акт «приема – передачи ЛС от пациента». Акт «приема-передачи ЛС от пациента» необходимо заполнить два экземпляра (один передать пациенту, второй поместить в место хранения ЛС).

3. В акте «приема-передачи ЛС от пациента» необходимо указать: наименование/ торговое название ЛС, дозировку, серию, срок годности и количество, форма выпуска (таб./амп.) ЛС, дату (число/месяц/год) передачи медикаментов, а также ФИО пациента, дежурной медицинской сестры, принимающей ЛП и лечащего врача или заведующего отделением. После заполнения акта, ЛС помещают в промаркированный контейнер («Личные ЛС пациента: ФИО, дата рождения»). Контейнер необходимо хранить в запирающимися на ключ шкафу для ЛС.

4. Лечащий врач вызывает врача-специалиста для консультации.

5. После консультации врача-специалиста и подтверждения обоснованности назначений, лечащий врач вносит в лист назначений все лекарственные средства, принимаемые пациентом.

6. Медицинская сестра проводит выдачу личных лекарственных средств пациенту по листу назначений в соответствии с алгоритмом выдачи лекарственных средств.

7. После выписки пациента все неиспользованные лекарственные средства возвращаются пациенту под личную подпись.

Форма акта приема – передачи ЛС:

Дата _____

ФИО дежурной медицинской сестры _____

ФИО лечащего врача/заведующего отделением_____

ФИО пациента _____

Дата рождения пациента_____

Переданы лекарственные средства:

Наименование ЛС	Форма выпуска (амп/таб.)	Серия	Срок годности	Количество

Подпись дежурной медицинской сестры _____

Подпись лечащего врача/зав. отделением_____

Подпись пациента_____

При выписке пациенту возвращены лекарственные средства:

Наименование ЛС	Форма выпуска (амп/таб.)	Серия	Срок годности	Количество

Подпись дежурной медицинской сестры _____

Подпись лечащего врача/зав. отделением_____

Подпись пациента_____

Приложение 18
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)
2024 год.

«Использование гигрометра психрометрического ВИТ-1, ВИТ-2».

Определение: Гигрометр **психрометрический** - прибор для определения относительной влажности атмосферного воздуха, т.е. отношения влажности окружающего воздуха к влажности насыщенного водяного пара при той же температуре и давлении.

1. Назначение: для измерения изменений относительной влажности воздуха и температурных показателей в закрытых помещениях, в местах хранения ЛП, ИМН, расходного материала.

2. Ответственность: старшая медицинская сестра, медицинские сестры.

3. Контроль исполнения процедуры: заведующие отделениями; старшие медицинские сестры, главная медицинская сестра.

4. Критерии оценки: соответствие СОП.

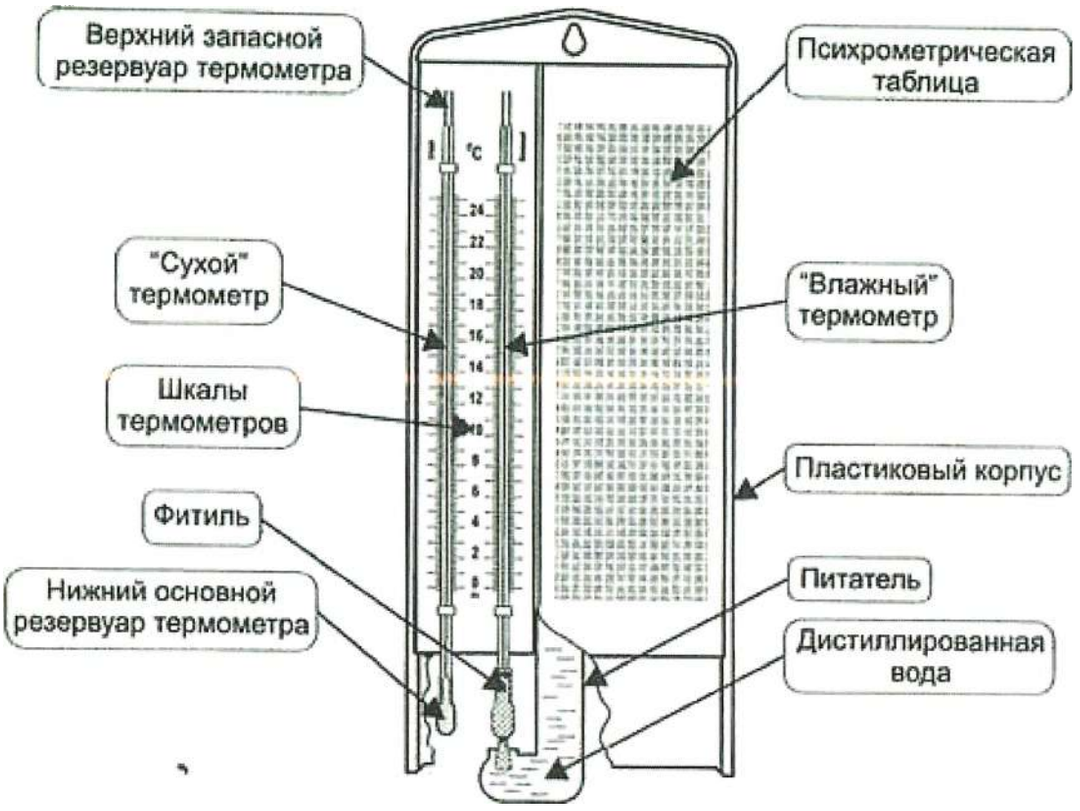
5. Область применения: посты медицинских сестер, процедурные кабинеты, перевязочные, манипуляционные кабинеты, кабинеты выдачи лекарственных препаратов в амбулаторных отделениях, помещения для хранения основного запаса ЛС и изделий медицинского назначения у старших медицинских сестер.

6. Оборудование и материалы:
– Гигрометр психрометрический ВИТ-1 или ВИТ-2
– Вода дистиллированная,
– Журнал учета показаний гигрометра психрометрического.

7. Этапы
I. Подготовка к процедуре
1. Подготовить все необходимое.
2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
II. Выполнение процедуры
1. Снять питатель с основания и заполнить дистиллированной водой, посредством погружения устройства запаянным наконечником вниз в резервуар с водой.
2. Установить питатель на основание так, чтобы расстояние между краем открытого конца питателя и резервуаром термометра было не меньше 20мм, а фитиль не касался стенок открытого конца питателя. Перед установкой питателя в рабочее положение смочите фитиль окунув резервуар мокрого термометра в питатель с водой.
3. Снять показания по «сухому» и «увлажненному» термометрам. При снятии показаний глаз работающего должен находиться на уровне горизонтальной касательной к мениску жидкости так, чтобы отметка шкалы в точке отсчета была видима прямолинейной. Работающий с гигрометром должен находиться от него на расстоянии нормальной видимости отметок шкалы и

остерегаться во время отсчетов дышать на термометры. При отсчете показаний термометров вначале быстро отсчитываются десятые доли градуса, затем целые градусы.

Важно: Минимальное время выдержки в измеряемой среде 30 мин.



4. Для начала следует определить значение температуры воздуха по термометру, расположенному слева, затем округлить его до целого числа в градусах Цельсия. Учитывая показания «мокрого» термометра, показывающего скорость испарения влаги, следует рассчитать разницу между полученными ранее и этими значениями. Далее, зная показатель, найти его по психрометрической таблице. Определите относительную влажность воздуха по психрометрической таблице. Искомая относительная влажность будет на пересечении строк температуры по "сухому" термометру и разности температур по "сухому" и "увлажненному" термометрам.

Важно: Гигрометр должен устанавливаться вертикально, на уровне глаз оператора, на внутренней стене помещения вдали от нагревательных приборов на высоте 1,5-1,7м от пола на расстоянии не менее 3 метров от двери. В месте монтажа устройства нужно исключить источники холода, тепла, способные создавать температурные колебания, превышающие 2°С.

Показания прибора снимать и регистрировать в журнале ежедневно (в начале смены), в т.ч. в выходные и праздничные дни!

При эксплуатации измерительного устройства запрещено:
- использовать для протирания психрометрической таблицы и шкалы термометров агрессивные средства - кислоту, растворители и аналогичные едкие жидкости;
- подвергать прибор ударному воздействию и при установке, и при дальнейшем использовании;
- допускать перегрев гигрометра серии ВИТ-1 свыше 45°С. Превышение указанного температурного уровня влечет повреждение резервуаров термометров или их полное разрушение.

ВАЖНО!!! Если произошло разрушение термометров устройства, толуол (термометрическая жидкость) должен быть незамедлительно удален с окружающих предметов раствором горячей воды с добавлением активных моющих средств. Стоит помнить, что толуол отличается повышенной токсичностью и огнеопасностью.

III. Окончание процедуры

1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.

2. Данные показания прибора зарегистрировать в журнале регистрации температуры воздуха и относительной влажности

IV. Техническое обслуживание

1 Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой по ГОСТ Р 58144-2018 (хранение дистиллированной воды при Т- от + 2 до + 35 гр. С., не более 7-ми дней после вскрытия потребительской упаковки).

2. Воду дополнять заблаговременно, лучше всего сразу после проведения измерений или не менее, чем за 30 минут до начала измерений влажности.

3. Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным. Меняйте фитиль 1 раз в месяц, при большей запыленности по мере загрязнения фитиля. Отметку о замене фитиля делаем в журнале регистрации температуры воздуха и относительной влажности.

4. Перед заменой удалите загрязненный фитиль и протрите резервуар тампоном ваты, смоченным теплой водой.

5. Для изготовления нового фитиля применяйте шнур-чулок хлопчатобумажный, а также допускается применение ткани хлопчатобумажной, отбеленной, неокрашенной, технической без аппрета по ГОСТ 29298-2005. Смочите фитиль в дистиллированной воде и натяните его на резервуар термометра так, чтобы была возможность завязать его ниткой над резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен быть не менее 7 мм.

6. Подготовьте две петли из ниток. Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитки. Вторую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно облегал резервуар. Петлю затяните не туго, а так, чтобы она не препятствовала капиллярному смачиванию ткани фитиля на резервуаре термометра.

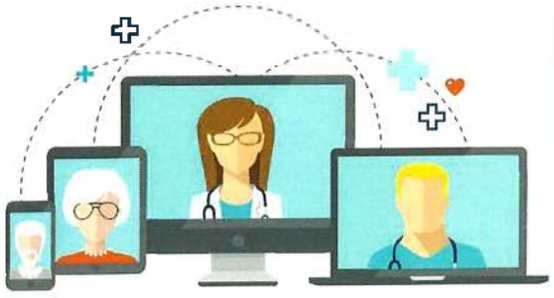
7. Гигрометр подвергается первичной и периодической поверкам. Первичная поверка проводится при выпуске из производства, периодическая поверка - один раз в два года в соответствии с методическими указаниями МИ-737-83 «Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методы и средства поверки», утвержденными в установленном порядке. Сведения о поверке гигрометра приведены в паспорте.

Приложение 19

к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»

от «21» мая 2024г. № 116/24

Алгоритм выдачи лекарственных средств по видеоконтролируемому лечению с использованием видеофайла



1. Врач оформляет информированное добровольное согласие на проведение лечения с использованием видеоконтроля

2. Врач оформляет лист назначения и памятку для пациента под роспись в кабинете

3. Участковая медсестра сопровождает пациента в процедурный кабинет с листом назначения, с подписью врача о назначении пациенту видеоконтролируемого лечения и сроком выдачи ПТП на 30 дней

4.Процедурная медсестра согласовывает с пациентом время, до которого он ежедневно отправляет на ее телефон путем (WatsApp, Телеграм или Viber) записанный видеофайл по приему лекарственных препаратов.

5. Процедурная медсестра детально объясняет пациенту как принимать препараты.

6. Ежедневно процедурная медсестра просматривает присланные видеофайлы. Оценивает полноту и правильность присланной информации (идентификация пациента, принимаемые препараты, дозы). Делает отметку в листе назначения. При наличии замечаний сообщает о них лечащему врачу

7. Еженедельно или по мере необходимости врач созванивается с пациентом, задает вопросы о текущем состоянии здоровья пациента, интересуется его самочувствием, возможными побочными эффектами после приема препаратов и выясняет, есть ли у пациента вопросы по лечению

8. Лечащий врач делает записи в медицинской карте пациента о состоявшимся видеозвонке

9. Если пациент не выходит на связь, то процедурная медсестра информирует участкового врача о пропуске в лечении

Приложение 20
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

Алгоритм выдачи лекарственных средств пациенту на амбулаторном этапе лечения

Лечащий врач фтизиатр назначает пациенту режим химиотерапии, оформляет лист врачебных назначений в котором указывает название препаратов , суточную дозу, кратность приема , связь с приемом пищи.

Медицинская сестра участковая сопровождает больного в кабинет выдачи лекарственных препаратов отдает лист врачебных назначений процедурной медсестре

Процедурная медсестра доброжелательно и уважительно представляется пациенту называет свою должность и ФИО. Идентифицирует пациента, просит его полностью назвать ФИО и полную дату рождения

Процедурная медсестра сравнивает данные идентификации пациента с данными в “Листе врачебных назначений (ФИО и дату рождения), при совпадении данных объясняет правило приема ЛС и спрашивает согласие на прием препаратов

Процедурная медсестра проводит санитарно-гигиеническую обработку рук антисептиком (согласно алгоритму).

На основании «Листа врачебных назначений» производит выдачу пациенту лекарственные средств (сверив название ЛС, дозировку, проверив срок годности на упаковке), в количестве, строго соответствующему и назначенному в листе врачебных назначений, но не более чем на 10дней. Предоставляет пациенту инструкцию на лекарственный препарат. Если таблетки в блистерах, то блистеры не разрезают. Если ЛП во флаконах, россыпью медсестра использует чистый пинцет (или ложку), отсчитывает нужное количество таблеток в пакетик. На пакетике медсестра пишет ФИО пациента, дату рождения полностью, наименование ЛП, дозировку, форму выпуска, номер серии, производитель и срок годности лекарственного средства.

После выдачи пациенту лекарственных препаратов, медсестра регистрирует выдачу ЛС в «Журнале выдачи противотуберкулезных препаратов» и «Журнале прихода и расхода ЛС подлежащих предметно-количественному учету». Просит пациента поставить подпись в журнале и ставит свою подпись.

Приложение 21
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

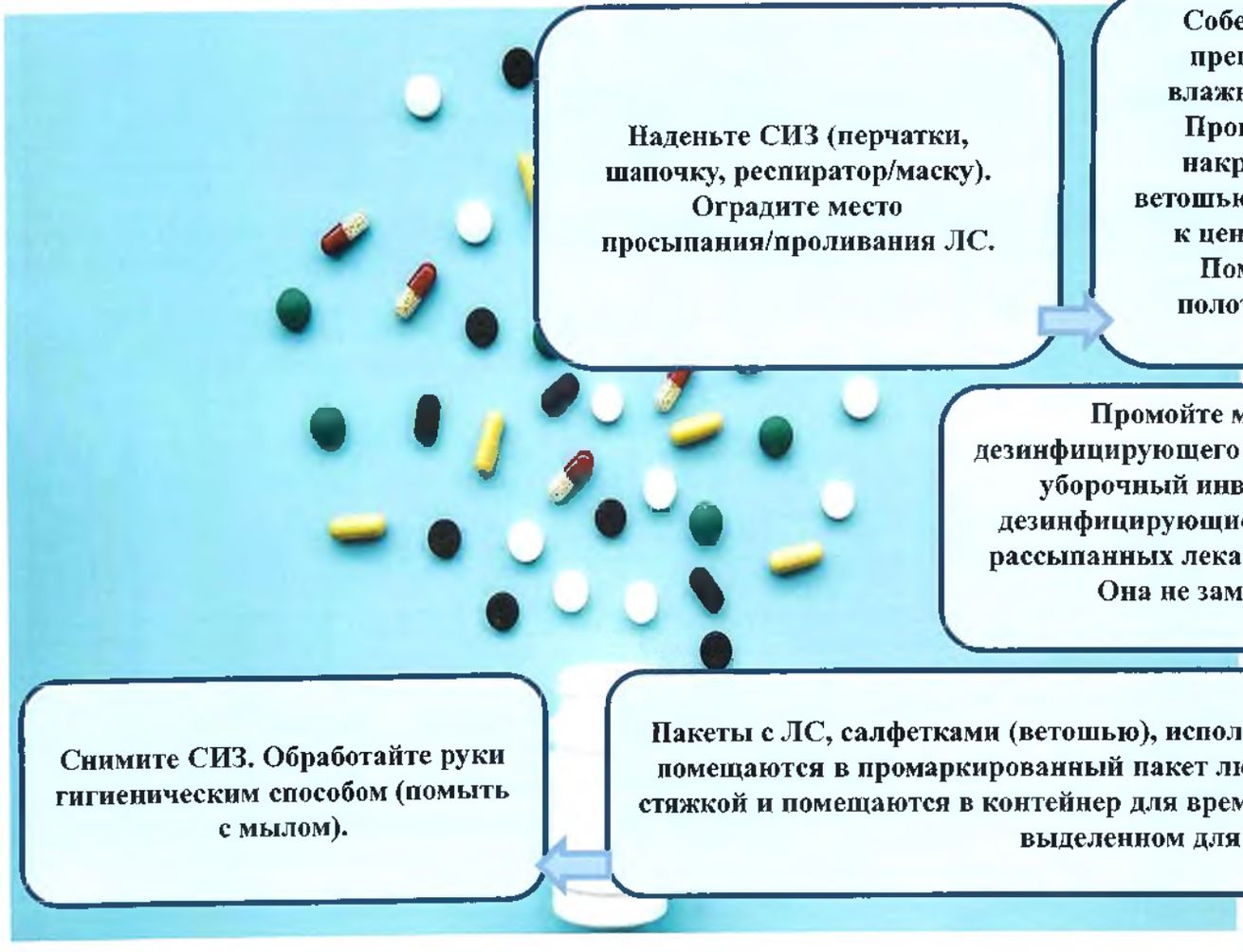
Памятка для медицинских сестер при работе с лекарственными средствами

При хранении лекарств запрещается:

- НЕЛЬЗЯ — Хранить ЛС вне первичной упаковки и без инструкции
- НЕЛЬЗЯ — Перефасовывать, пересыпать, переливать ЛС из первичной упаковки
- НЕЛЬЗЯ — Объединять ЛС из разных упаковок в одну
- НЕЛЬЗЯ — Переливать технические жидкости в емкости из-под лекарств
- НЕЛЬЗЯ — Разрезать первичную упаковку
- НЕЛЬЗЯ — Хранить вскрытые ампулы и флаконы
- НЕЛЬЗЯ — Хранить светочувствительные ЛС на свету
- НЕЛЬЗЯ — Хранить ЛС в одних шкафах с МИ
- НЕЛЬЗЯ — Хранить упаковки ЛС в перевернутом виде
- НЕЛЬЗЯ — Хранить ЛС в одном помещении с дезсредствами
- НЕЛЬЗЯ — Закрывать наименование, серию, срок годности ЛС маркировочным стикером
- НЕЛЬЗЯ — Делать надписи на упаковках ЛС

Приложение 22
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

Алгоритм действий персонала при проливании или рассыпании лекарственных средств



Наденьте СИЗ (перчатки, шапочку, респиратор/маску). Оградите место просыпания/проливания ЛС.

Соберите салфеткой рассыпанные лекарственные препараты. Соберите порошкообразные средства влажными одноразовыми бумажными полотенцами. Проведите уборку жидких лекарственных средств накрыв их сухими бумажными салфетками (сухой ветошью), собираем жидкость с внешних границ разлива к центру бумажными салфетками (сухой ветошью). Поместите собранные ЛС, салфетки, бумажные полотенца в пакет любого цвета (кроме красного и желтого).

Промойте место рассыпания/проливания раствором дезинфицирующего средства. Используйте для этого маркированный уборочный инвентарь, соответствующей зоны. Применяйте дезинфицирующие растворы по инструкции. Уборка пролитых и рассыпанных лекарственных средств — это экстренная процедура. Она не заменяет плановые мероприятия по уборке.

Пакеты с ЛС, салфетками (ветошью), использованными для сбора рассыпанных/разлитых ЛС, помещаются в промаркированный пакет любого цвета, кроме красного и желтого, затягивают стяжкой и помещаются в контейнер для временного хранения медицинских отходов класса «Г» в выделенном для этих целей помещении.

Снимите СИЗ. Обработайте руки гигиеническим способом (помыть с мылом).

Приложение 23
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

_____

(наименование лекарственного средства для медицинского применения)

_____

(дозировка, лекарственная форма, единица измерения)

Месяц	Остаток на 1-е число месяца	Приход		Всего за месяц по приходу с остатком	Виды расхода	Расход					Расход за месяц по каждому виду отдельно	Всего за месяц по всем видам расходов	Остаток по журналу учета на конец месяца	Фактический остаток на конец месяца	Подпись уполномоченного лица
		Поставщик, N и дата документа	Количество			1	2	3	4	5 и т.д.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Январь					по рецептам										
					по требованиям										
Февраль и т.д.					по рецептам										
					по требованиям										

Приложение 24
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

Журнал учета движения ИЛП (для Диаскин-теста, туберкулина)

Клиника/филиал/аптека_____

Приход									Расход					
Дата поступления	Название ИЛП	Производитель	Поставщик	Серия	Срок годности	Количество доз/фасовка	Тип и контрольный номер термоиндикатора	Показания термоиндикатора	Дата отпуска	Кому отпущено	Количество доз/фасовка	Остаток (доз)	Тип и контрольный номер термоиндикатора	Показания термоиндикатора

Приложение 25
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТРАНСПОРТИРОВКИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Клиника _____отделение _____

№ п/п	Наименование компонентов крови	№ наклад	Изготовитель	Дата, время получ.	T° в контейнере в момент получ. ВУСК	При поступлении в МО				Ответственный за транспортировку		Ответственный за получение	
						Дата, время	Документация	T° в контейнере	Макро оценка	Подпись	Расшифровка подписи	Подпись	Расшифровка подписи

Приложение 26
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

_____
(наименование лекарственного средства для медицинского применения)

_____
(дозировка, лекарственная форма, единица измерения)

Месяц	Остаток на 1-е число месяца	Приход			Всего за месяц по приходу с остатком	Расход			Всего расход за месяц	Остаток по журналу учета на конец месяца	Фактический остаток на конец месяца	Подпись уполномоченного лица
		От кого получено	N и дата документа	Количество		Дата выдачи	N медицинского документа (амб. карта, ИБ) (Ф.И.О. пациента получившего препарат)	Количество				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Январь												
Февраль												
Март												

Приложение 27
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

Журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании

Дата	Время	Показания термометров				Показания термоиндикаторов			
		N 1	N 2	№ 3	№ 4 И т.д.	N 1		N 2	
						Идентификационный номер	Показания	Идентификационный номер	Показания
01.01.24г.	*9.00*	*+5*	*+5*				*Норма*		*Норма*
	17.00	*+5*	*+5*				*Норма*		*Норма*
02.01.24г.	*9.00*	*+5*	*+5*				*Норма*		*Норма*
	17.00	*+5*	*+5*				*Норма*		*Норма*

Приложение 28
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Клиника/филиал_____отделение _____ помещение _____

Дата	Время	Показания сухого термометра	Показания влажного термометра	Разность показаний сухого и влажного термометров	Влажность	ФИО, подпись ответственного лица

Приложение 30
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «21» мая 2024г. № 116/24

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТРАНСПОРТИРОВКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ТЕРМОМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Клиника _____отделение _____

№ п/п	Наименование ЛС	№ наклад	Изготовитель	Дата, время получ.	T° в контейнере в момент получ.	При поступлении в МО				Ответственный за транспортировку		Ответственный за получение	
						Дата, время	Документация	T° в контейнере	Макро оценка	Подпись	Расшифровка подписи	Подпись	Расшифровка подписи

Лист согласования проекта приказа

«Об обращении лекарственных средств и медицинских изделий в ГБУЗ МО «МОКПТД»

Должность	ФИО	Дата	согласовано/подпись
Заместитель главного врача по медицинской части	Лапырева Ирина Алексеевна	14.05.2024	
Заместитель главного врача по КЭР	Горбунова Елена Владимировна	14.05.2024	
Заведующий аптекой	Синаторова Олеся Олеговна		

Нач. юрид. отдела Новиков К. Н.
согласовано 21.05.2024